Asociación de Psicopatología
y Psicoanálisis de Sevilla

JOSÉ MANUEL GARCÍA ARROYO

COMUNICACIÓN ASISTENCIAL PARA MÉDICOS

I PARTE: ASPECTOS GENERALES

El presente libro ha recibido la MENCIÓN DE HONOR
del Grupo de Investigación para la Salud en Ciencias Humana (IPSUM)

Comunicación Asistencial para Médicos. Parte I: Aspectos Generales
José Manuel García Arroyo
Editado por la Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de Sevilla
Luis Montoto, 83 – 3º C
41018 Sevilla (España)
Luysa.dl@gmail.com

ISBN: 978-84-09-29506-7
Depósito Legal: SE-242-21
Diseño, maquetación e impresión: Gabella Artes Gráficas.
Impreso en España. Printed in Spain.

Reservados todos los derechos.

Queda rigurosamente prohibido, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.

El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar.

PERICLES

Dedicado a María Luisa, por la buena comunicación que mantenemos, a pesar de las dificultades que surjan.

INDICE

Presentación.

PRIMERA PARTE. Teoría de la comunicación.

Capítulo 1º. La comunicación: Concepto. Funciones. Modelos y estructura.

- **1.1. La necesidad de comunicarnos.**
- 1.2. Concepto de comunicación.
- 1.3. Funciones y su aplicación a la Medicina.
  - 1.3.1. Referencial.
  - 1.3.2. Expresiva.
  - 1.3.3. Directiva (o promotora).
  - 1.3.4. Relacional.
  - 1.3.5. Narrativa.
  - 1.3.6. Metalingüística.
- 1.4. Modelos de comunicación.
  - 1.4.1. Modelo clásico.
  - 1.4.2. Teoría matemática de la comunicación.
  - 1.4.3. La Escuela de Palo Alto.
- 1.5. Estructura.
  - 1.5.1. Emisor.
  - 1.5.2. Mensaje.
  - 1.5.3. Canal.
  - 1.5.4. Código.
  - 1.5.5. Receptor.
  - 1.5.6. Contexto.

Capítulo 2º. Comunicación y espacio social. Comunicación verbal y no verbal. La proxemia.

- 2.1. La comunicación verbal.
  - 2.1.1. Los signos verbales.
  - 2.1.2. Características.
  - 2.1.3. Funciones.
- 2.2. La comunicación no verbal.
  - 2.2.1. Concepto.
  - 2.2.2. Componentes.
  - 2.2.3. Funciones.
  - 2.2.4. La indecibilidad de los actos.
- 2.3. La proxemia.
  - 2.3.1. Concepto.
  - 2.3.2. Tipología.
  - 2.3.3. Factores que intervienen.

PRESENTACIÓN

Comunicación Asistencial es una asignatura de reciente aparición en los programas del Grado en Medicina, que se imparte como Formación Básica junto a otras materias de sobra conocidas por todos (Anatomía, Fisiología, Histología, etc.). Su implantación, más que un capricho de las Instituciones que organizan la Formación Médica, representa una necesidad debido a que se han venido observando problemas en la comunicación entre médico y paciente, de manera que esta resulta fundamental para que se produzca un buen desarrollo de la práctica clínica. Esto demuestra que no solo hace falta información en materia médica (mecanismos fisiopatológicos, síntomas de las distintas enfermedades, conocimiento de las pruebas diagnósticas, etc.), sino una formación humanística que posibilite el desarrollo de un encuentro adecuado con el enfermo. De ahí, que en Medicina sea necesario aprender estrategias y habilidades de comunicación con el mismo rigor con que se asimilan las técnicas exploratorias y/o diagnósticas.

No significa que el médico tenga que ser un comunicador, dado que no es periodista, ni locutor de radio, ni presentador de televisión sino que (necesariamente) tiene que adquirir unas nociones básicas de comunicación para poder relacionarse de modo satisfactorio con las personas que acuden consultarle.

¿Por qué Comunicación Asistencial? La respuesta se halla en el cambio de planteamientos que venido produciendo respecto a la enfermedad y, por extensión, a la propia profesión médica. Antiguamente, aquella se entendía exclusivamente términos biológicos, dado que se trataba tan solo de salvar vidas; las enfermedades más prevalentes eran las agudas, las infecciosas o los accidentes que mermaban a la población (epidemias, traumatismos fatales, procesos contagiosos, etc.). El desarrollo de las condiciones higiénico-sanitarias y los avances bio-médicos han dado lugar a un aumento de la longevidad y a la aparición de las enfermedades crónicas. Eso ha provocado que el contacto con el paciente se dilate más que en las épocas precedentes y, por consiguiente, a que resurjan los aspectos más personales de la relación y también a considerar la intervención de nuevos factores en el enfermar (hábitos, contactos, grado de información, creencias erróneas, comportamientos, etc.). En todo este entramado hay que añadir la prevención como parte fundamental de la actividad profesional, lo que supone intervenciones del médico como educador, un papel que antes no aparecía por ningún lado.

De ahí la necesidad de incluir a la persona en el proceso asistencial; este interés ha promovido el desarrollo de numerosas disciplinas orientadas hacia este mismo fin (Psicología de la Salud, Psicología Conductual, Medicina Psicosomática, etc.). Se trata de una pretensión que viene de lejos; así, Victor von Weizäekker (1) habló de “introducción del sujeto en Medicina” y Laín Entralgo (2) de “personificación del enfermo”; hablamos de la necesidad de humanizar la

Medicina y, en consecuencia, de no abordar a quién viene a consultar como un mero cuerpo enfermo; más que eso, se trata de un ser humano que padece (*pathos*). Pero, cuidado, porque este noble afán no puede conducir a olvidarse de los procesos físicos del enfermar, es decir, que se trata de crear algo nuevo aparte de la Medicina Biológica pero sin sustituirla o prescindir de ella.

La aparición del modelo bio-psico-social de Engel (3) (se estudia en Psicología Médica) representa en la actualidad un avance al considerar que las condiciones físicas son necesarias, aunque no son suficientes, para explicar los hechos clínicos (modelo biomédico). Este nuevo esquema va a permitir ubicar la Comunicación Asistencial en la formación del estudiante y, sobre todo, diferenciarla de la Psicología Médica, de la que no puede considerarse una "segunda parte". En el esquema siguiente presentamos la existencia de tres niveles de organización: el biológico (B), el psicológico (P) y el social (S) y, aunque cada uno se apoya en el anterior (el S en P y el P en B) y no existe sin él (p. ej. no pueden considerarse los grupos -nivel S- sin las personas que lo constituyen -nivel P-), conservan su propia autonomía. A cada nivel le corresponde un sistema (respectivamente: organismo, sujeto, comunidad), manteniendo de forma independiente sus propias leyes (p. ej. las sustancias químicas que se producen, como son las hormonas o los neurotransmisores, se incluyen en el organismo, mientras que los mecanismos de defensa se relacionan con el sujeto) (4).

Nivel	**Sistema**	**Contenido**	**Materia**
Social	Comunidad	Cultura del enfermar (normas y valores)	**COMUNICACIÓN ASISTENCIAL**
Psicológico	Sujeto	Enfermo (conductas y experiencias)	PSICOLOGÍA MÉDICA
Biológico	Organismo	Enfermedad (síntomas y signos)	MEDICINA

Pues bien, el contenido que se le da a cada uno de estos niveles y sistemas es el siguiente:

-al nivel B le corresponde la enfermedad, con sus síntomas y signos característicos, y es estudiada por la Medicina,

-en cambio, la Psicología Médica trata del enfermo, donde toman gran valor las conductas y las experiencias de este respecto a su patología. Obsérvese que

los síntomas y signos de la enfermedad son idénticos en cualquier lugar del Planeta (p. ej. la esclerosis lateral amiotrófica –ELA- se presenta igual en Sevilla que en San Petersburgo), pero no ocurre lo mismo con las experiencias y comportamientos asociados a un determinado trastorno, pues se encuentran influidos por las directrices del medio en el que la persona se desenvuelve y por las propias características de esta última.

-Finalmente, al nivel S le corresponde la “cultura del enfermar” y ahí es donde la Comunicación Asistencial tiene su sitio, pues intenta abordar las normas y valores relacionados con la enfermedad que el paciente adopta por el hecho de pertenecer a un ambiente socio-cultural concreto y también cómo el profesional de la Medicina puede desarrollar comportamientos propicios para que la interacción se despliegue adecuadamente.

Además, la Comunicación Asistencial incluye el asunto de la “Relación Médico-Enfermo” (RME) que, realmente, es un tema de la Psicología Médica, pero se aborda aquí (4). No es un capricho para complicar la asignatura sino que, sobre la RME, se asienta todo el proceso comunicativo y aborda cualquier interacción social que se dé entre los dos personajes que intervienen en esta diada (médico y paciente) y, por extensión, a los vínculos personales y comunicacionales que se establezcan entre el paciente y su familia, de los propios pacientes entre sí o entre el médico y la familia de este.

Con la aparición de la Comunicación Asistencial se completa la visión global del paciente, que supera los esquemas reduccionistas anteriores y aporta al médico las herramientas necesarias para interaccionar correctamente con los enfermos, con otros profesionales de la salud y con la comunidad a la que pertenece. De estos planteamientos, se deducen una serie de objetivos a cumplir:

1º) Incluir en la Formación Médica la estructura y funcionamiento de la RME que va a constituirse en la base de la comunicación, es decir, no se puede entender la última de ellas sin entender la primera.

2º) Definir la importancia de la comunicación en la RME, con una doble vertiente:

a) Respecto al paciente. La comunicación representa un puente entre las aportaciones de la medicina biológica y el trabajo individual con la persona que acude solicitando ayuda y, en este sentido, se tienen que considerar sus características personales y sociales, pues no puede tratarse de la misma forma a un paciente que a otro (p. ej. no es lo mismo que sea miedoso o que le dé igual de todo), con lo que puede establecerse un trato diferencial de acuerdo con la personalidad y sus mecanismos. Además, va a permitir una comunicación eficaz con el enfermo y su familia, lo que redundará en unos mejores resultados en la práctica.

b) En relación al médico. Se intenta promover actitudes adecuadas para obtener una RME eficaz y, en este orden de cosas, estudiante tendrá que desarrollar una mayor sensibilidad en el trato con las personas en general y con los enfermos, en particular. Se procura que aprendan ciertas habilidades de comunicación, quiere decir, modos de proceder que le permitan el acercamiento a la persona enferma e interactuar con ella. Como objetivo fundamental de esta materia consideramos el saber manejar la información adecuadamente, lo que implica:

-Recogerla: una acción imposible si no se sabe escuchar.

-Comprenderla: implica saber analizarla, sintetizarla y ordenarla.

-Transmitirla: aspecto relacionado con saber hablar y escribir.

-Guardarla: no se puede llevar a cabo sin la confidencialidad, un valor a desarrollar por el médico desde que inicia sus estudios, dado que estamos tratando con los aspectos más íntimos de la persona.

-Registrarla: para ello hace falta conocer y utilizar las tecnologías de la información. Este subapartado se asocia, tanto con saber almacenar los datos del paciente en los sistemas informáticos al uso, como obtener información a través Internet o conectar con otros centros para intercambiar conocimientos. Son acciones necesarias en el complejo Sistema de Salud en el que trabajamos, pero su utilización no puede dar lugar al olvido de que se tiene delante a alguien que lo está pasando mal con su proceso patógeno.

Se añade que el médico también tiene que comunicarse con otros profesionales de la salud e incluso con la sociedad, a través de los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.). Con este último punto, desaparece aquella visión del médico solitario, aislado en su consulta, atendiendo a una sucesión interminable de pacientes. Hoy en día, esta postura es insostenible, dado que tiene que participar en investigaciones, congresos, reuniones científicas, debates sobre su especialidad y, de manera ocasional, en los medios públicos de difusión de la información (p. ej. si forma parte de una investigación novedosa, si trata a alguna persona influyente, etc.)

El despliegue de estos objetivos se separa en 17 capítulos, agrupados en tres módulos, los cuáles van a publicarse en forma de pequeños libros. Hacerlo así no es por simple antojo, sino que tiene un interés didáctico, fácil de reconocer: en épocas pretéritas los libros de Medicina eran verdaderos tochos, algunos con más de 1000 páginas y nunca eran leídos por los estudiantes; tan solo servían como material de consulta de ciertos temas y abordados, con un poco más profundidad, por los residentes y especialistas. Los libros pequeños tienen la ventaja de resultar manejables y, por consiguiente, más controlables al provocar la sensación de ligereza, no desanimando a unos estudiantes ya sobrecargados

al tener que llevar adelante varias materias al mismo tiempo. Se resalta, en esta forma de presentación, la agilidad de lectura y la comodidad.

Veamos ahora cuáles son los Módulos a desarrollar:

I) Al primero lo titulamos “Aspectos generales” y aborda la Teoría de la Comunicación” (Libro 1º). En él se explican los fundamentos teóricos generales de la comunicación y se aportan los conceptos básicos que van a utilizarse en el resto de la materia. Es evidente que no se puede aplicar a la Medicina los distintos elementos comunicacionales, si no se conocen cuáles son; en este sentido, se estudiarán qué son: el mensaje, el receptor, el espacio en la comunicación, la interacción verbal, el valor comunicativo de los gestos, el contexto, etc. Como decimos, tendrán una aplicación inmediata en capítulos posteriores.

II) El segundo trata de la Comunicación Asistencial como “Proceso Social” (libro 2º). Aquí se muestran ciertos elementos prácticos para poder interaccionar con los enfermos, pensando la Medicina como una práctica social (o psico-social). Partiendo de la Relación Clínica se abordan los distintos Modelos Asistenciales con los que contamos y, con ello, se intenta planificar un diseño adecuado de RME sobre la base del marco asistencial. Las habilidades de comunicación tendrán un lugar privilegiado en este apartado, aprendiendo a escuchar y a desarrollar estrategias para utilizarlas en la interacción. Los modernos planteamientos de la “narrativa médica” (6) van a potenciar el contacto empático con el paciente y, a este último, a encontrar un significado a su sufrimiento, teniendo en cuenta que se trata siempre de una construcción subjetiva. Con ello se reconoce que cada consultante tiene una historia que contar y, cuando habla, lo hace en forma de narración y el médico tiene que aprender a recibir y a manejar tales relatos (7). Así pues, la pretensión es darle la palabra al paciente en el proceso asistencial, creando un clima en el que la narrativa sobre la enfermedad permita detectar sus necesidades y expectativas de curación.

Lo aprendido en este Módulo va a usarse directamente en la “entrevista clínica”, en la que se dan cita las estrategias, habilidades y actitudes asimiladas (léase “subjetivadas”) de los capítulos anteriores; pero, se trata de una “entrevista centrada en el paciente”, que contrasta vivamente con la “entrevista centrada en el médico y en la enfermedad”, que es la que se ha venido realizando hasta el momento, sustentada en el clásico modelo biomédico (5). En una entrevista de este estilo, se intenta ganar la confianza del paciente para que relate aquellos aspectos más personales que sabemos interfieren en la enfermedad. No se trata del simple morbo de escuchar intimidades, sino de contar con elementos relevantes en el proceso patológico.

Va a trabajarse también cómo la información obtenida queda plasmada en documentos, como es el caso de: la historia clínica, el informe, los registros

informáticos, etc.; esto debe realizarse de forma comprensible, utilizando la narrativa y sabiendo qué puede figurar y qué no en los papeles o en los registros informáticos.

III) En el último de los Módulos propuestos, llamado: “Aplicaciones de la Comunicación Asistencial” (libro 3º), se aplica todo lo estudiado antes a la práctica médica, tal como se da en la realidad. Concretamente, veremos las características particulares de la RME en diferentes contextos en los que el profesional de la Medicina puede desempeñar su labor y cómo se establece el contacto en cada uno de ellos, tal es el caso de: la hospitalización, las UCIs, las situaciones de crisis, los enfermos terminales o aquellas circunstancias en las que existen dificultades de comunicación (niños, ancianos, deficientes, barreras idiomáticas o culturales, etc.).

Un tema de especial importancia va a ser el de operar con las “malas noticias”; tengamos presente que en la actualidad no es posible delegar esta función en cualquier otro miembro del equipo sanitario (p. ej. en el/la enfermero/a) y donde la actuación no puede ser arbitraria, sino medida. Se completará el apartado con la comunicación en determinados contextos (entre los propios profesionales de la salud, los trabajos científicos -en congresos o en artículos de revistas-, informes, etc.) y finalizaremos con el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones del médico con los medios de comunicación.

Ciertamente, si el médico incorpora algunos principios dirigidos a favorecer el contacto con quiénes acuden a él buscando ayuda, como los se muestran en los capítulos que siguen, sus actuaciones tendrán un impacto directo en la práctica. Este aserto se pone de manifiesto en la aparición de cambios favorables en los enfermos, como pueden ser: la adherencia al tratamiento, el cumplimiento de las indicaciones, la ausencia de retrasos a la hora de consultar y de abandonos terapéuticos y la satisfacción por parte de aquellos. No hace falta ser un genio darse cuenta de que, cualquiera de los fenómenos citados, en su sentido negativo, son mucho más probables si la comunicación brilla por su ausencia; contamos con numerosos estudios que así lo demuestran.

Asimismo, la aplicación de las propuestas de Comunicación Asistencial permitirán al médico adaptarse a los cambios más recientes del “rol de enfermo”, sobre todo los referidos a que: se trata de una persona ilustrada, tiene cada vez más información en su poder y demanda participar en la toma de decisiones sobre su salud. Se trata de modificaciones que corren parejas a la necesidad de abandonar, por parte del médico, del “papel paternalista” que hasta ahora ha venido desarrollando y que toma el control absoluto sobre la relación, tomando decisiones que le corresponden al paciente y no a él. En fin, el aspirante a ejercer la Medicina debería saber que su práctica no es una “veterinaria especializada en el género *homo*”, sino que se encuentra inserta en un campo de relaciones interpersonales (trabaja con personas), lo que le conduce a considerar los

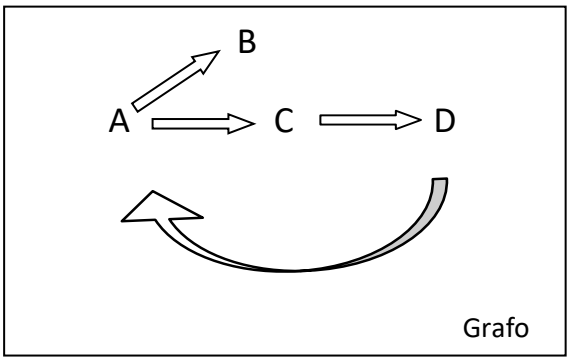
aspectos inherentes a estas como parte integrante del proceso de curación y de los cuidados que presta.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), creada en el año 2002 como organismo dependiente del Ministerio de Universidades, cuya misión es velar por la calidad del Sistema de Educación Superior, ha elaborado los llamados “Libros Blancos”. En ellos se definen los diferentes estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo Superior (EES) y permiten una reflexión sobre los mismos; pues bien, existe un Libro Blanco que define los objetivos y competencias del Grado en Medicina (conviene buscarlo en Internet y leerlo en algún momento). Este texto da la importancia debida a la Comunicación y se refiere a asuntos ya indicados antes, como: habilidades de comunicación, modelos de relación clínica, entrevista, elementos de comunicación verbal y no verbal, interferencias, etc.

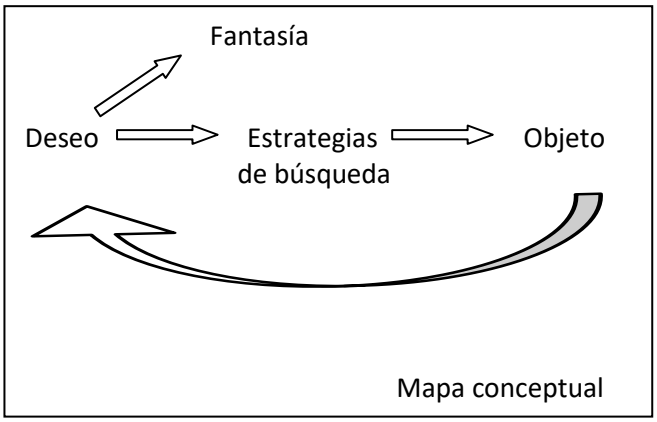
Para acabar esta Presentación, solo resta indicar el modo de desarrollar la Comunicación Asistencial en los capítulos sucesivos. En las exposiciones se utilizarán dos recursos (comunicativos) que ya han prestado un gran servicio antes:

-Por un lado, los “recortes clínicos”, que son pequeños trocitos de historiales clínicos reales. Tienen una grandísima utilidad ya que aportan un contenido a los conceptos propuestos, permitiendo que la enseñanza teórica tenga una versión práctica imprescindible. En esta línea, quién realiza la lectura puede asociar automáticamente un “referente” (de la realidad) a un “concepto” básico, no quedando este último desnudo; más tarde, al evocar dicho concepto, puede acordarse del reporte clínico y su conocimiento queda totalmente asegurado. Recuerdo encuentros con alumnos míos de años anteriores que me comentaron cómo, al hablar con tal o cuál enfermo, identificaron un mecanismo a partir de rememorar un caso que conté en clase; ¡justamente ese es el objetivo!

-Por otro, los llamados “mapas conceptuales”. Tienen como punto de partida la “teoría de grafos” del gran matemático Euler (8) y que fue aplicada exitosamente a diferentes campos (circuitos eléctricos, recorridos turísticos, líneas de metro, migraciones de animales, etc.). Sirven en Psicología y en Comunicación para organizar y representar el conocimiento en forma de grafos, en cuyos vértices se encuentran los conceptos, mientras que las aristas muestran las relaciones entre ellos, formando una tupida red (9,10). Los “mapas conceptuales” permiten de un “golpe de vista” contemplar la complejidad del asunto tratado y establecer relaciones significativas entre sus componentes, facilitando la comprensión de los puntos fundamentales del tema y que puedan surgir preguntas. Veamos un ejemplo:



Este grafo puede emplearse para explicar la “dinámica de las conductas sexuales”, tan solo con sustituir cada uno de los vértices (representados por las letras A, B, C y D) por palabras, del siguiente modo:



Véase como se ha obtenido un “mapa conceptual”, con el que puede explicarse el asunto sometido a análisis. Las letras (A, B, C, D) se cambian por conceptos (deseo, objeto, fantasía, etc.) y las aristas (flechas) explican las relaciones entre dichos conceptos (p. ej. el deseo puede canalizarse hacia la fantasía o hacia la realidad -en forma de “estrategias de búsqueda”-); se observa, además, que el grafo es recursivo, pues vuelve otra vez a empezar desde el principio (lo que manifiesta que el deseo humano es “eterno”).

Una vez que hemos presentado el contenido de los bloques temáticos y la forma de abordar la materia, estamos ya en condiciones de comenzar la exposición. Solo queda desear que el material que sigue sea del agrado de los lectores y, más que nada, que sea útil para que la práctica médica se transforme en un acto más humano y esperanzador.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Von Weizsäecker V. Escritos de antropología médica. Buenos Aires: Zorzal, 2009.
2. Laín Entralgo P. La medicina actual. Madrid: Seminarios y Ediciones, 1973.
3. Engel GL. The need for a new medical model: A challenge for Biomedicine. Science 1977: 196: 129-136.
4. Castiilla del Pino C. Introducción a la Psiquiatría (vol. 1). Madrid: Alianza Universidad, 1993.
5. García Arroyo JM. Proyecto Docente e Investigador de Psicología Médica. Universidad de Sevilla, 2020.
6. Charon R. Narrative Medicine: A Model for Empathy, Reflection, Profession and Trust. JAMA 2001;286(15):1897–1902.
7. Brown J, Thorton T, Stewart M. Challenges and solutions: narratives of patient-centered care. United Kingdom: Radcliffe Publishing; 2012.
8. Alsina C. Mapas de metro y redes neuronales. La teoría de grafos. Madrid: RBA, 2010.
9. Novak JD, Musonda D. A twelve-year longitudinal study of science concept learning. Am Educ Research Jourr 1991; 20(1): 117-153.
10. Novak JD, Gowin DB. Learning how to learn. New York: Cambrid Univesity Press, 1984.

PRIMERA PARTE: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN.

Capítulo 1º.- La comunicación: Concepto. Funciones. Modelos y estructura.

Antes de entrar en la aplicación específica de los procesos comunicativos a la Medicina parece necesario tratar de la Teoría de la Comunicación, tal como la conocemos hoy en día. De ahí que, en esta Primera Parte, intentemos cumplir los siguientes objetivos:

a) describir cómo es la comunicación humana,

b) comprender su complejidad,

c) preparar el terreno a la práctica médica, para que el profesional de la Medicina pueda intervenir acertadamente en distintas situaciones, algunas de las cuáles pueden ser difíciles y

d) aportar los conceptos imprescindibles para dicha aplicación.

No se trata de hacer lingüística, ni semiótica, ni periodismo, sino de entender lo imprescindible sobre la comunicación, cuáles son sus funciones y los elementos que contiene (Cap. 1º), para pasar a tratar los aspectos verbales y extraverbales de la misma, sin olvidar el espacio en el que la interacción se produce (Cap. 2º). Dada la novedad de los conceptos que se muestran, su presentación será progresiva sin dar nada por sentado.

1.1. La necesidad de comunicarnos.

La palabra “comunicación” viene del verbo latino *communicare*, que se traduce como “estar en común”, “poner en relación” o “compartir” y apunta a que, al comunicarse, la gente participa, convive. Se trata de algo inherente al ser humano, dado que la sociedad es impensable sin la comunicación y hasta es posible decir que aquella se construye sobre esta última. Cualquier acción, por insignificante que parezca (p. ej. pagar una factura en el banco, comprar lotería, sacar una entrada de cine, pedir la comida en un restaurante chino, etc.), se acompaña del empleo de signos para explicar lo que queremos; en consecuencia, nuestra realización como personas sería imposible fuera del marco comunicativo.

A su vez, la comunicación se sostiene en la necesidad que tenemos los humanos de convivir unos con otros, hasta llegar a crear la macroestructura que es la sociedad. Los psiquiatras conocemos a la perfección esta necesidad y lo que sucede cuando se producen experiencias de aislamiento (voluntarias o accidentales), en las que el sujeto enloquece, llegando a aparecer síntomas psíquicos característicos. Veamos un caso histórico que lo ilustra bastante bien (1):

> *A un médico llamado Lindeman se le ocurrió atravesar el Atlántico completamente solo en un bote plegable, en una travesía que duró dos meses y medio. Aunque se preparó psicológicamente a conciencia, durante más de un año, con idea de protegerse de los riesgos de la experiencia, en*

las últimas semanas aparecieron ciertos sucesos desagradables. Estos consistían en escuchar extrañas voces que lo llamaban o le advertían del peligro; incluso algunos objetos del bote tomaron la forma de figura humana; el médico reconoce fácilmente en estos fenómenos la presencia de alucinaciones visuales y auditivas.

Menos suerte tuvo Isidoro Arias, patrón de barco experimentado, que decidió (en 2001) cumplir su gran sueño: dar la vuelta al mundo en solitario en una pequeña embarcación. También se preparó para la travesía: revisando puertos seguros donde atracar, rutas marinas, previsiones meteorológicas, corrientes, vientos,… Partió de Benalmádena y se mantuvo en contacto con familiares, amigos y seguidores mediante Internet y un teléfono vía satélite. A la vuelta, casi concluido ya el viaje, su familia empezó a recibir ciertos mensajes inquietantes; en ellos aseguraba que un grupo de criaturas subían a bordo desde hacía varias jornadas y le estaban importunando. Parecía confuso e incoherente. Cuando se encontró el barco, Isidoro no se hallaba a bordo y misteriosamente había desaparecido.

En numerosas situaciones de aislamiento (experimentales o no) la persona implicada termina padeciendo fenómenos similares, ilustrando claramente que el humano no está hecho para encontrarse solo y, cuando se aísla, no es que tenga "hambre de estímulos", como se ha dicho, sino de la "presencia de sus semejantes". Podemos decir que, si no existen los demás, estos aparecen alucinatoriamente.

De la necesidad de estar con los congéneres nace la conciencia de pertenencia a una comunidad ("yo como individuo no estoy aislado, sino que me integro en un grupo de semejantes"), que implica formar parte de la misma y participar, lo cual se aproxima bastante al sentido de *communicare*.

1.2. Concepto de comunicación.

Genéricamente, se ha entendido por esta "el intercambio de material psicológico (opiniones, experiencias, sentimientos, afectos, ideas, ...) entre dos o más personas, por cualquier medio (escritura, habla, gestos,...). Trátase de una definición demasiado general y tal vez contaminada por los aspectos psicológicos; de ahí que se requieran ciertas matizaciones.

Más específicamente, o si se prefiere más técnicamente, se habla de un "proceso mediante el cual se transmite información entre un hablante y un oyente, que utilizan el mismo código", quiere decir que existe un procedimiento por cuya intercesión un sujeto establece contacto con otro, permitiéndole difundir cierto contenido informativo (p. ej. contarle a un amigo qué sucedió en su fiesta de cumpleaños).

En esta última definición, hallamos tres elementos que interesan destacarse:

-el código,

-la información y

-las personas que intervienen en el proceso.

El código es el conjunto de signos que todos tenemos en nuestra mente o "espacio subjetivo", con los cuáles podemos transmitir la información.

$$C = \{S_i\} = \{S_1, S_2, S_3, \ldots, S_n\}$$

Respecto a la información indicar que sin ella no podemos vivir, pues no se podrían solucionar los problemas, ni tampoco tomar decisiones y mucho menos afrontar ciertas circunstancias de la vida. Para que esta transmisión sea efectiva se requieren dos condiciones:

1ª. Compartir el mismo repertorio de signos. Los signos pueden ser:

-Palabras, lo que implica tener el mismo idioma (el español); si el sujeto habla en otra lengua diferente necesitamos a un tercero que traduzca las expresiones utilizadas, que intervenga en el lugar del código. A veces nos cuenta entender a los pacientes psicóticos debido a que inventan signos que no existen en nuestro código compartido (neologismos) o utilizan signos con un significado completamente diferente al común (paralogismos).

> *Un esquizofrénico joven cuando hablaba repetía la palabra "seto", sin venir a cuento en su discurso: "he venido a verlo a usted de buen grado, seto. Esta vez no me ha obligado nadie a acudir, seto. Ya sabe que antes no quería, seto…". La palabra "seto" en el diccionario de la RAE significa: "cercado hecho de matas o arbustos", pero no es a lo que el paciente se refiere. Para entenderlo, tenemos que pedirle que traduzca la palabra y, rápidamente, dice: "seto significa se-to, que sé-todo"; alude a que sabe que algo oculto se está tramando a sus espaldas, más allá de las simples apariencias, engañosas en sí mismas.*

Ya sea porque no se hable el mismo idioma o por producir un lenguaje con términos inexistentes (neologismos o paralogismos), aparece un mensaje que no transmite nada, aunque eso no impide, como luego veremos, que la comunicación se siga produciendo.

-Imágenes. Peirce (2), padre de la semiótica, hablaba de "iconos" en estos casos. Aquí se consideran ciertas imágenes que transmiten una información directa debido a la analogía que existe entre lo que muestra y lo que significa. Tal es el caso de las figuras que representan los distintos deportes; si miramos detenidamente las siguientes imágenes, fácilmente se puede distinguir el deporte que se relaciona con cada una de ellas (boxeo, ciclismo, etc.).



En los servicios también encontramos iconos característicos que separan los que son de caballeros de los de señoras. El psicoanalista francés Jacques Lacan hablaba de la “ley de segregación urinaria”: contamos con dos lugares diferenciados para hacer nuestras necesidades por el hecho de tener dos aparatos genitales diferentes, algo inédito en los animales (no existen árboles para orinar los perros y otros para las perras, con señales independientes).



Asimismo, en los hospitales y centros sanitarios hallamos diferentes iconos, dirigidos a los pacientes, que han de ser fácilmente identificables por estos. Cuando la relación entre una imagen y su significado no queda clara, se requiere una explicación adicional mediante palabras; esto sucede con los ordenadores, donde hay que “pinchar” cada imagen para que salga automáticamente un pequeño rótulo que informa de qué se trata.

Recordemos que la Semiótica es la ciencia que se dedica al estudio del funcionamiento de los sistemas de signos.

2ª. Tener idénticas reglas de combinación de los signos entre sí, llamadas “reglas semióticas”. Los signos tienen que relacionarse entre ellos de una forma correcta, de lo contrario se imposibilita la transmisión de información. Esto no reviste demasiada dificultad en los iconos, debido a la transparencia que tienen y a la relación clara con el contexto en el que se presentan; así, sería un error que apareciera una imagen referida a un deporte en una farmacia o en una panadería.

Si pueden producirse más problemas cuando el código considerado es lingüístico, ya que se requiere forzosamente un orden preciso de presentación de las palabras. También en los psicóticos se altera esta propiedad y así, un paciente

decía: “plutonio verdea en ceniceros de óbito” (3); en esta frase no se entiende absolutamente nada, aunque puede comprobarse que los signos son correctos, pero no están bien conectados entre sí.

La información se transmite en forma de mensajes, los cuáles se constituyen en la unidad de la comunicación, lo mismo que existen unidades de medida para los distintos fenómenos físicos (p. ej. el grado para la temperatura, la hora respecto al tiempo, el vatio con la potencia, el gramo en relación al peso, etc.). Por consiguiente, en comunicación van a estudiarse cómo se estructuran, producen y reciben los distintos mensajes.

Comunicar significa transmitir información o, lo que es igual, intercambiar mensajes entre individuos. Luego, importa tanto la información transmitida como los sujetos que intervienen en ella; esta postura va a tener un gran predicamento, como veremos más tarde, sobre todo a partir del impulso ejercido por la Escuela de Palo Alto que se desarrolló en Norteamérica; por ahí, va a continuar este asunto de las personas que intervienen en el proceso comunicativo.

1.3. Funciones de la comunicación y su aplicación a la Medicina.

Siempre que interaccionamos las personas lo hacemos con una intención concreta (transmitir un pensamiento, dar una orden, romper el hielo en una conversación, manipular, conmover, dar pena, etc.). Roman Jakobson (4) clasifica las funciones del lenguaje según cuál sea la intencionalidad del acto comunicativo en sí mismo; así, siguiendo a este lingüista de origen ruso, existen seis funciones reconocidas:

1.3.1. Referencial. Informa sobre los objetos y acontecimientos, por eso se centra en la relación que los hablantes tienen con el mundo. Si digo “Marta se casó el viernes” o “la luz tiene naturaleza corpuscular y ondulatoria” estoy aportando un contenido a quiénes me escuchan. Al mismo tiempo, mis oyentes reciben dicho contenido que, a partir de ahora va a formar parte de ellos, siendo a veces, trascendental para la vida de la persona (p. ej. el conocimiento de un peligro o un diagnóstico).

Para resaltar la función referencial se recurre a una entonación lo más neutra posible, sin énfasis, para no mostrar emotividad alguna y es, justamente, lo que ocurre en las noticias, crónicas o reportajes. Hay tener en cuenta, no obstante, que la objetividad de la información jamás puede ser absoluta, ya que siempre en el acto comunicativo participan otras funciones. Dicho de otra manera: convertir los hechos en mensaje implica un efecto de paso por el hablante y considerar que los hechos están relacionados con su entorno (personal, social, familiar,…) pero, si se intenta ser lo más objetivo posible, hay que obviarlos, lo cual no es posible enteramente. Veamos un ejemplo:

> *Si escribo un artículo científico procuro eliminar aquellos elementos personales míos, que delaten mis propias ideas o incluso debo procurar separarme de la institución a la que pertenezco. Pero, aunque lo intente con todas mis fuerzas, quién lea mi escrito se percata de qué línea sigo, como abordo el tema e incluso si alguna empresa ha pagado mi estudio. Luego, es imposible ser completamente aséptico al expresarse.*

De todas formas, si se puede intentar informar lo más fielmente posible procurando utilizar un lenguaje claro, conciso y sencillo, atando lo más posible los términos que empleo.

1.3.2. Expresiva. Tiene que ver con los deseos, emociones, sentimientos o estados de ánimo de quién habla. Esta función indica que, además de transmitir información, el hablante puede expresar su actitud ante lo que dice y, con ello, añadir al mensaje su estado o intención e, incluso desde fuera, pueden descubrirse ciertos rasgos de su personalidad. Si digo: “no me gustó la película, era demasiado larga”, existe algo de mí que pongo en la frase y quién me escucha puede realizar distintas interpretaciones sobre mí (p. ej. “no le gusta realmente el cine”, “es impaciente”, “quiere que todo sea rápido”, etc.).

Puede afirmarse, entonces, que en el proceso comunicativo la palabra transmite algo más de lo que dice (contenido informativo), difunde ciertos aspectos de quién habla que, a veces, se intentan ocultar para no ser descubierto en sus propósitos; de ahí que exista un material subyacente a lo que se comunica que no se desea revelar. Veamos un ejemplo:

> *Un varón de 25 años presenta una patología llamada “donjuanismo”; solo le interesan las conquistas y no establecer vínculos afectivos con las mujeres. Al acercarse a una, intenta siempre conocer cuáles son sus gustos y preferencias para acoplarse completamente a ellos. Así las cosas, no desea ser descubierto en su pretensión exclusiva de llevar a cabo la conquista; para lograrlo, tiene que actuar camuflándose para que ella no se dé cuenta de dichas pretensiones. No obstante su celo, en numerosas ocasiones es descubierto, pasando rápidamente a la acción con otra mujer, no importándole quién esta sea.*

1.3.3. Directiva (o promotora). En este caso, se intenta influir sobre el oyente y moverlo a actuar en una dirección determinada, de ahí que se asocie a los mandatos o a las órdenes. Esta función se resalta en expresiones como las siguientes: “¡no llegues después de las 11!” o “¡cómete todo el cocido!”. A veces puede mostrarse de una forma más sutil o por lo menos no tan tajante (p. ej. “te recomiendo que no dejes comida en el plato” o “sería bueno que no llegaras tarde”). De modo extremo, puede manifestarse lo mismo añadiendo cierta coacción, cosa que puede realizarse en determinados contextos; quedará más claro con algunos ejemplos:

Una madre le decía lo siguiente a su hija (paciente mía): "puedes llegar a casa a la hora que quieras, pero si llegas tarde yo estaré preocupada y no podré dormir".

Un marido le decía a su mujer (que acude a consultar): "eres libre de salir con tus amigas pero, si lo haces, no cuentes más conmigo porque esta relación se va a acabar".

Véase el efecto coactivo tan importante que se da en ambos casos (chantaje afectivo).

1.3.4. Relacional. También llamada "función fática" y tiene que ver con establecer, prolongar o mantener el contacto entre los hablantes. Intenta que no se corte el funcionamiento del circuito comunicativo y, para ello, se utilizan frases que no informan de nada (p. ej. si digo "hace buen día" o "está lloviendo", mi interlocutor lo sabe perfectamente). Intervenciones de este estilo son necesarias porque con ellas facilitamos el intercambio social, pero su empleo no aporta nada nuevo, ya que se conoce perfectamente el mensaje transmitido.

El contenido expresado no tiene por qué referirse siempre al tiempo atmosférico que, ciertamente, es lo más inmediato y socorrido debido a su evidencia (p. ej. "hace calor" o "ha subido la temperatura"), sino que puede asociarse a circunstancias conocidas por todos (p. ej. "Ha visto como han invadido el Capitolio", "Ha subido la factura de la luz" o "Los disturbios en Barcelona están llegando ya demasiado lejos"). Esta función se encuentra exagerada en personas que no pueden estar calladas (los llamamos "histriónicos") y siempre tienen algo que decir, para no sentirse solas; las conversaciones que plantean suelen ser absolutamente intrascendentes y aburren a los demás, sin siquiera ellos/as apercibirse. En cambio, los fóbicos no pueden pronunciar ni siquiera cualquiera de estas socorridas frases.

Análogamente, las presentaciones e inicios del contacto emplean esta función como recurso, tal sucede en las reuniones científicas (p. ej.: "aquí a mi derecha tengo al Dr. Pérez, un eminente cirujano, que va a hablar sobre la cirugía gástrica". Queda claro que todos lo conocen, pero es una forma de empezar la conferencia, apareciendo igualmente cuando se realizan entrevistas a políticos, personajes mediáticos, cantantes o profesionales eminentes.

1.3.5. Narrativa. Se trata, en esta ocasión, de elaborar historias. La persona que narra puede servirse de ciertos recursos retóricos que tienen como objetivo crear belleza con el mensaje. Es la función predominante en el lenguaje literario donde importa más cómo se dice que aquello que se dice (p. ej. una novela no tiene por qué ser fiel a los hechos), pero no hace falta ser un escritor para ejercerla pues, cuando se cuenta lo que ocurrió en una entrevista de trabajo, en el fin de semana o en un viaje realizado suelen utilizarse ciertos recursos narrativos (p. ej. el suspense, empezar por lo menos importante e ir a más,

presentarlo en orden cronológico, dejar al otro con la intriga, resaltar quiénes son los “buenos” y quiénes los “malos”, etc.).

1.3.6. Metalingüística. Como su nombre indica, es aquella que se refiere al propio lenguaje. Para que se entienda bien, veamos las dos frases siguientes:

Madrid es la capital de España

Madrid es un sustantivo

La primera tiene como referencia a un objeto del mundo: una ciudad, por lo tanto se está empleando la función referencial. En cambio, la segunda no se refiere a Madrid como objeto sino a un término del lenguaje, un sustantivo (Madrid), en cuyo caso se emplea la función metalingüística.

Esta función puede usarse, pongamos por caso, para definir una palabra (p. ej. una “zarza” es un “arbusto espinoso”; un “cetáceo” es un “mamífero marino de gran tamaño”) o también para referirse a las expresiones del propio lenguaje (p. ej. “Madrid es la capital de España” es una oración simple).

El médico debe conocer y saber ejercitar estas funciones cuando actúa con sus pacientes y, mientras mejor las utilice, más versatilidad comunicativa va a tener; por eso, resulta necesario relacionarlas con la práctica médica.

1) La función **referencial** permite:

-Recoger los datos del enfermo y, si se realiza correctamente, se obtiene una mayor exactitud en la historia clínica.

-El paciente puede tomar conciencia de los problemas de salud que padece, cuando se le transmite una información adecuada.

-El médico puede analizar los hábitos y valores relacionados con la salud de su paciente y cómo estos influyen en la patología presente.

Evidentemente, mientras más información tengamos, mejores intervenciones pueden realizarse con los enfermos.

2) Por medio de la función **expresiva** se consigue que:

-El paciente pueda poner de manifiesto el sufrimiento. Este no solo habla de los síntomas de su enfermedad (dolor, fiebre, anorexia, cansancio, etc.) (información), sino como le afectan estos en su vida (expresión). Si bien los primeros suelen ser parecidos para todos los consultantes, la respuesta afectiva a las manifestaciones clínicas es diferente por completo.

-Puede descargar las tensiones que trae y conseguir cierto alivio. Cuando estudiemos la “comunicación emocional” vamos a referirnos a este aspecto particular, por ahora solo lo dejamos apuntado.

3) La función **promotora**, si se realiza correctamente, puede lograr:

-Una mayor adherencia y cumplimiento del tratamiento prescrito.

-Modificar ciertas conductas que suponen un riesgo para la salud ("conductas de riesgo").

-Estimular la toma de decisiones. Es importante saber que no se pueden tomar las decisiones por el enfermo (p. ej. de las distintas posibilidades terapéuticas, cuál debe seguir), dado que es éste quién debe hallar la salida. Esto tiene que ver con que la responsabilidad sobre su vida no es del médico sino de él.

-Advertir de los peligros potenciales. Si la persona va a meterse en un grave problema, el profesional de la Medicina puede intervenir mostrándole las consecuencias que pueden seguirse, caso de realizar esa acción (p. ej. meterse en un negocio ruinoso).

-Promover la salud entre los individuos, familias o comunidades. Aquí es posible advertir sobre las conductas saludables en distintos medios.

4) La función **fática** posibilita:

-Establecer una adecuada relación con el paciente. Permite tratarlo adecuadamente (conociendo sus condiciones personales y sociales) y saber cómo establecer y mantener el diálogo con él, en cuyo caso la respuesta suele ser positiva.

-Si lo anterior se produce, surgirán menos demandas judiciales y reclamaciones; téngase presente que los malos entendidos aparecen con más frecuencia cuando no se establece buen contacto con la persona que se tiene delante.

-La comprensión también es una consecuencia de esta función, ya que si se establece "buen contacto" con enfermo, se abre más y aporta más datos, con lo que se pueden entender mejor sus motivaciones y reacciones.

5) Mediante la función **narrativa** se consigue:

-Redactar buenas historias clínicas. Una historia bien hecha no es una colección de síntomas apilados uno tras otro, sino aquella que adopta una forma de relato que detalla toda la diacronía de la enfermedad; así, los síntomas quedan hilvanados entre sí adquiriendo una coherencia interna.

-La comunicación del médico con la comunidad científica. Los resultados de una investigación no solo tienen que ser fieles al material estudiado, sino que han de presentarse de tal manera que los colegas puedan entender de qué se

trata; de ahí que dichos resultados tienen que adquirir una forma literaria (narrativa).

6) La función **metalingüística** permite definir correctamente los términos que se usan en Medicina para que:

-El enfermo sepa lo que se le está diciendo. Utilizamos habitualmente una jerga profesional que contiene un lenguaje complicado que, evidentemente, quién acude buscando ayuda no entiende. Si no se traducen los términos al lenguaje común es imposible que el mensaje llegue a su destino.

> *A una paciente de 50 años su cirujano le dijo: "después de haberle hecho una biopsia de mama, hemos descubierto células atípicas, pero cálmese usted porque se trata de un carcinoma in situ". La paciente respondió: "no sé de qué me habla. No he entendido ni una sola palabra de lo que me ha dicho". Encima, el médico se sorprendió de la respuesta que le dió.*

-No se sigan dando las definiciones incorrectas, tal como las emplea el gran público. Estas deformaciones son frecuentes y lo hemos visto, de una manera bastante clara, en cáncer de mama (5); cuando se diagnostica a una mujer de esta enfermedad, inmediatamente asocia "cáncer" a "deterioro" o a "muerte" y, sin embargo, sabemos que la tasa de curación es muy alta cuando el diagnóstico precoz. Por lo tanto, "cáncer" no es igual a "muerte" y, cuando se explica esto a las pacientes (y definen el problema de otra forma), se les abre un nuevo camino.

-También es posible pensar esta función en relación a lo que la persona puede decir en la consulta y no fuera de ella. Comprender el significado de tales palabras en relación al medio en el que se pronuncian resulta fundamental; en efecto, existen ciertos vocablos que no se pueden decir en la calle y sí en el ambiente íntimo y reservado de un consultorio (p. ej. prácticas sexuales, sentimientos negativos hacia los miembros de la familia, separación matrimonial, etc.).

1.4. Modelos de comunicación.

1.4.1. Modelo Clásico. El primer modelo lo hallamos en la antigua Grecia y se relaciona con la intensa actividad política que existía en ese momento en las *Polis* (nombre del que deriva "política"). El objetivo de esta sistematización era convencer al auditorio de ciertas ideas; se pensaba que un político no solo debía tener buenos argumentos, sino que debía conmover al auditorio. Fue Aristóteles, en su *Retórica*, quién define los componentes de la comunicación:

ORADOR → DISCURSO → AUDITORIO.

-El orador es la persona que habla (la oratoria es el arte de la persuasión a través de la palabra hablada).

-El discurso es lo que se dice.

-El auditorio es el conjunto de las personas que escuchan.

Se trata de un modelo unidireccional en el que resulta imprescindible la persuasión del auditorio.

1.4.2. Teoría Matemática de la Comunicación. Mucho tiempo después, con el despliegue de los medios de comunicación y las correspondientes tecnologías, apareció la "Teoría Matemática", desarrollada por Claude Shannon y Warren Weaver, en los años 40. Estos autores parten de las ciencias exactas (matemáticas e ingeniería) e intentan darle a la comunicación un estatuto científico; en 1949 publican un libro conjunto, titulado: *The Mathematical Theory of Communication.*

Se desarrolla en el seno de las telecomunicaciones, con la pretensión mejorar la eficacia de la transmisión de la información y el desafío consiste en encontrar una manera de difundir la mayor cantidad de mensajes posibles, con la menor interferencia posible (el ruido, en tanto perturbación intolerable) y al menor costo posible. Trata de interacciones entre máquinas, no entre seres humanos y, a pesar de ello, durante un tiempo se ha considerado como "el *modelo* de la comunicación".

Se presenta como un esquema lineal que ignora a los sujetos que intervienen en el proceso, no teniendo en cuenta los numerosos aspectos que pueden intervenir (ideas, creencias, sentimientos, planteamientos, contexto sociocultural, etc.), de ahí que haya que emplear otros modelos que se acerquen más a la realidad humana. La buena noticia es que ha aportado dos nociones importantes:

-la de *código* y

-la de *feed-back*.

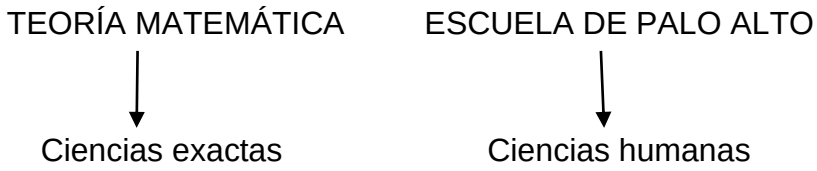
El último de ellos es un concepto acuñado por Norbert Wiener, profesor de Shannon, e implica la idea de que, aquello que llega al final del proceso comunicativo, hace reaccionar a quién recibe la información y, tal efecto, influye sobre quién la emite de modo retroactivo (p. ej. cuando alguien habla fuerte obliga a subir el tono a su oyente lo que, paralelamente, hace que el primero de ellos aumente su intensidad y así sucesivamente). Con esta contribución, Wiener se separa del esquema lineal antes citado, una idea que va a ser clave en el siguiente Modelo que estudiamos.

1.4.3. La Escuela de Palo Alto (California). El último que presentamos es el de la Escuela de Palo Alto, que se desarrolla entre los años 40 y 50 del siglo pasado en esta localidad al sur de S. Francisco. Se denomina también "Colegio

Invisible", debido a que sus miembros no pertenecen formalmente a la misma institución.

En ella se dan cita una serie de investigadores norteamericanos, pertenecientes a distintos campos científicos (antropólogos, sociólogos, biólogos, lingüistas,..), donde ocupan un lugar destacado los psiquiatras. Hasta ahora veíamos a estos especialistas tan solo como alienistas recluidos en manicomios y, mira por donde, han tenido un papel destacadísimo en el nacimiento de las teorías sobre la comunicación humana. Son representantes del Colegio Invisible, entre otros: Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Edward T. Hall, Don D. Jackson y Jurgen Ruesch.

Como grupo se oponen a la fría Teoría Matemática, antes expuesta, e inscriben la comunicación, no ya en las ciencias exactas, sino en las ciencias humanas. Plantean aquella como una interacción social, que se convierte en la base de cualquier relación interpersonal. Conjuntamente definen la comunicación como: "la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas" (6).



La comunicación se transforma en un proceso permanente, que integra múltiples y indisociables elementos (palabra, gesto, mirada, mímica, espacio individual, rol, estatus, etc.), dado que cualquier comportamiento tiene valor comunicativo, no tratándose de un proceso lineal, sino circular. En este último aspecto contemplamos ecos de Wiener y se refiere, insistimos una vez más, en el hecho de que, quién recibe la información reacciona y, a su vez, provoca un efecto en la persona que inició el proceso (retroalimentación o *feed-back*). Según esta visión, es un error trasladar lo que sucede en los sistemas eléctricos a la comunicación humana.

Por si fuera poco, la Escuela de Palo Alto se atreve con los enfermos mentales, llegando a precisar que los trastornos psíquicos reflejan las perturbaciones de la comunicación entre el individuo y su entorno. Incluso profundizan en el entorno social de los enfermos, lanzando una hipótesis bastante interesante sobre la esquizofrenia.

Paul Watzlawick estudia la comunicación, no como se produciría de una forma ideal, sino como se da de hecho entre los seres humanos (visión pragmática) y define los "**axiomas de la comunicación"** (7). El término "axioma", empleado en matemáticas, se refiere a proposiciones aceptadas como verdaderas sin necesidad de demostración alguna y, a partir de ellas, pueden deducirse otras nuevas (teoremas). Pues bien, los axiomas formulados por Watzlawick son los siguientes:

Primer axioma. No es posible no comunicar. Dado que siempre nos estamos comportando y todo comportamiento es comunicativo, siempre nos estamos comunicando. Llega hasta el punto de que si una persona permanece callada, aunque no diga nada está comunicándose y "comunica que no quiere comunicar" (p. ej. "indica a los demás que lo dejen en paz"). El silencio mismo es un mensaje (p. ej. si le digo a un paciente algo que no le agrada y no responde, está indicándome su desagrado con lo que le he expuesto).

Por consiguiente, aunque un sujeto lo intente con todas sus fuerzas, no puede dejar de interaccionar. Incluso, en aquellos problemas de código (por desconocimiento del idioma, por patología psíquica) la intención comunicativa existe. Veamos un ejemplo:

> *Ingresó en la sala de psiquiatría una paciente japonesa que no sabía hablar castellano y tampoco inglés y, cuando vinieron los padres, se descubrió que solo hablaban japonés. Ante la ausencia de un código común, se llevaron todo el tiempo saludando: doblaban el tronco hacia delante, una y otra vez. Dado el problema a nivel verbal, recurrieron a lo extraverbal para que el canal comunicativo permaneciera abierto.*

Ciertos aspectos, que normalmente pasan desapercibidos para cualquiera, también transmiten información; tal es el caso de dejar asientos libres en una reunión o conferencia; aquí existe la indicación expresa de: "necesito cierto espacio para poder estar cómodo".

Segundo axioma. Se separa "contenido" de "relación". Cualquier acto comunicativo contiene estos dos niveles bien diferenciados y consisten en:

-Lo que se dice: se limita a las palabras y se refiere al contenido del mensaje transmitido, que puede ser verdadero o falso, válido o no.

-Como se dice. Al mismo tiempo que se aporta un contenido, se propone un modo de relación al interlocutor (p. ej. broma, orden, discrepancia, cuestionamiento, insulto, etc.); en última instancia, se trata de cómo queremos que el otro comprenda lo que le decimos. Veamos un par de ejemplos:

> *No es lo mismo que yo indique en la clase con voz suave: ¿me han entendido? a que utilice la misma expresión con una alta intensidad de voz. Mientras que, en el primer caso, actúo amablemente para que el grupo se entere de lo que expongo, en el segundo muestro mi enfado porque los asistentes están hablando y/o molestándome.*

> *Puedo decir "cuídate mucho" de muchas maneras. Una de ellas es deseándole lo mejor a mi interlocutor y procurando que evite lo malo que pueda acaecerle; la relación que se establece es de amistad paternalista. Otra forma sería pronunciar la frase enfáticamente, en cuyo caso le estoy indicando que "vaya con cuidado" porque le puede pasar algo malo, que es lo que realmente deseo para él.*

Obsérvese que, aunque el contenido pueda ser el mismo, no así la relación que se establece y cómo esta última matiza o clasifica al primero de ellos. Los conflictos en la comunicación no se deben tanto a lo que se dice, sino a como se dice.

Tercer axioma. La naturaleza de la relación depende de la puntuación, de la secuencia de comunicación entre los interlocutores. Dado que dos personas no pueden hablar al mismo tiempo, ya que los mensajes se montan unos encima de los otros, tienen forzosamente que existir pausas para que el interlocutor reaccione ante lo que se le ha dicho y reaccione en consecuencia. Ya vimos que el proceso comunicativo es constante pero las pausas pueden variar, tratándose de una secuencia interrumpida de intercambios. De no ser así, lo que priva el monólogo y la comunicación quedaría definida como "solo quiero que me escuches, yo no quiero saber nada tuyo":

> *Este es el caso de tres chicas sentadas en un velador. La primera hablaba de que su suegra se iría a vivir con ellos (vive con su novio), lo cual es detestable. La segunda se refería a un problema que tenía con una asignatura y que le costaría bastante sacarla. El discurso de la tercera se refería a lo que iba a hacer en las cortas vacaciones que tenía. Ninguna escuchaba a las demás y las conversaciones se montaban unas encima de otras: "pues como mi suegra venga, la vamos a tener…", "sí, pero yo no quiero quedarme sin vacaciones otra vez…", "tendrás tú vacaciones, porque yo tengo que sacar la asignatura", "os digo que mi suegra es insoportable", etc. Si se observa bien, las tres monologan.*

Un efecto observado por Watzlawick, relacionado con este axioma, consiste en que cada uno de los que intervienen en la interacción cree que su comportamiento (efecto) tiene su origen en las acciones del otro (causa); se trata de un error común pues, más bien estamos ante un proceso circular. Un par de casos ilustrará bastante bien este efecto:

> *Una madre le indica a su hijo: "te riño porque nunca me echas cuenta", mientras que el último de ellos dice: "No te echo cuenta porque siempre me estás riñendo". Cada uno de ellos cree que su comportamiento lo provoca el otro*
>
> *Una mujer le expresa a su marido: "Tengo que controlarte porque siempre vas a tu aire y nunca haces caso a lo que te digo", en tanto que el último afirma: "No te hago ningún caso porque siempre me estás controlando".*

Cuarto axioma. Los humanos utilizamos comunicación digital y analógica. El hombre es un único organismo vivo capaz de hacer esta distinción, que se refiere a la separación entre:

-La forma verbal de comunicarse, que emplea las palabras (digital). Es la más reciente en su aparición y la más abstracta; se encarga de transmitir conocimientos, es decir, información sobre los objetos, y

-La no verbal, mucho más arcaica (analógica) e incluye: los gestos, las posturas, inflexiones de la voz, etc. Se encarga de transmitir el contacto entre los sujetos que comunican (proximidad-lejanía, afecto-frialdad, respeto-burla, etc.)

El lector aventajado se habrá dado ya cuenta de la relación que existe entre este axioma y el segundo, de manera que pueden asociarse estas dos parejas: contenido-digital y relación-analógica, si bien ambos no pueden confundirse.

Quinto axioma. Todo intercambio comunicativo es simétrico o complementario. En el primero de ellos se da la igualdad entre los miembros que intervienen en el contacto, como es el caso de los hermanos, amigos, amantes, compañeros de trabajo, etc.

$$A = B$$

En el complementario existe una diferencia, de tal forma que se establece una relación de superioridad-inferioridad entre los sujetos que participan, hallándose determinado por los roles sociales; es lo que sucede en los contactos: padre-hijo, profesor-alumno, jefe-empleado, mayor-joven, sargento-soldado, madre-hijo, fuerte-débil, etc.

$$A > B$$

Estas interacciones (igualdad-diferencia) matizan el proceso comunicativo y pueden dar lugar a importantes reflexiones, como ocurre en el ámbito familiar: existen padres que se ponen a la altura de sus hijos, lo cual es inviable (p. ej. se van de copas con ellos, visten de la misma forma, dicen los mismos disparates, adoptan el mismo lenguaje, fuman porros, etc.).

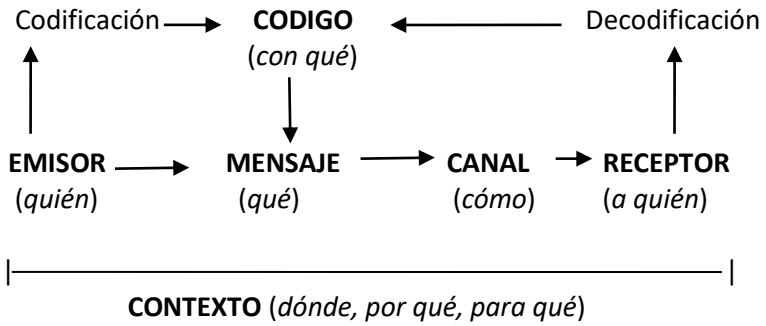
Como corolario de lo anterior, es posible decir que la Escuela de Palo Alto incide en que comunicar es producir un **sentido** en la interacción y esta es una afirmación muy novedosa, que tendrá importantes consecuencias en la comunicación médica. Un ejemplo muy conocido puede aclararlo:

> *La noche del 30 de octubre de 1938, el actor y director cinematográfico Orson Welles tomaba el micrófono en la radio y describía una noticia inédita, al tiempo que espeluznante: la (supuesta) invasión de los marcianos a la Tierra. Con su alegato consiguió aterrorizar a millones de norteamericanos, llegando a confundir a la población que, creyendo que se trataba de un hecho real, entraron en pánico. Simplemente había narrado la novela titulada "La guerra de los mundos" de G.H. Wells (publicada en 1898). Lo asombroso fue que su intervención radiofónica fue creída, implicando que entre el actor y la población se creó un sentido inexistente hasta entonces, de carácter imaginario. Finalmente, Welles tuvo que pedir disculpas públicas.*

1.5. Estructura de la comunicación.

El norteamericano Harold Lasswell (8) establece los diferentes elementos de la comunicación en su célebre artículo (de 1948) titulado: *Estructura y función de la comunicación en la sociedad.* Para él, entender este complejo proceso, implica responder a las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿a quién?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué?

Las correspondientes respuestas dan cuenta de los distintos elementos constitutivos del proceso comunicativo, que lo configuran como tal y son los que se muestran en el siguiente grafo y que se desarrolla en el texto:



1.5.1. Emisor. La persona que inicia el acto comunicativo y, por lo tanto, transmite la información; responde al *quién*. Decide de qué manera va a realizar esta acción y, para lograrlo, tiene que extraer del código los signos adecuados dando lugar a un material transmisible (proceso de codificación). Al mismo tiempo, sobre el emisor recae la función expresiva ya que al decir algo pone de manifiesto una actitud (cuestiona, opina, critica, riñe, etc.).

1.5.2. Mensaje. Se trata del contenido informativo enviado en forma de habla, respondiendo al *qué* y es el resultado del proceso codificador. Se le relaciona con la función narrativa, de manera tal que el propio mensaje puede llegar a alcanzar corrección, notoriedad y hasta belleza. Podemos detenernos ahora en dos características del mensaje:

-Una de ellas es el *fading rápido* que consiste en la transitoriedad de lo dicho; efectivamente, el material transmitido desaparece velozmente y de forma irrecuperable. Estamos ante una propiedad que impide que los mensajes ya emitidos se amontonen, cubran desordenadamente el canal comunicativo e imposibiliten la transmisión de otros nuevos. Gracias al *fading* los contenidos urgentes tienen vía libre de expresión. De no ser así, la experiencia se convierte en devastadora; veamos un ejemplo:

> *Un paciente que tomaba drogas de diseño, ingirió una que le produjo como efecto que los mensajes no desaparecieran. Fue un momento en el que entró en una iglesia sevillana a descansar, sentándose en un banco. El*

cura estaba rezando el Padre Nuestro y empezó a escucharlo, pero lo dicho previamente seguía persistiendo en la realidad; así escuchaba: "Padre Nuestro que estás en los Cielos" y luego: "santificado sea tu Nombre" y al mismo tiempo se repetía la frase anterior: "Padre Nuestro que…". Después continuaba el rezo: "venga a nosotros tu Reino" y al mismo tiempo: "que estás en los Cielos" y "santificado sea tu Nombre". Véase el gran problema que existe cuando no se produce el fading, de manera que la comunicación se hace imposible.

-Otra es la *prevaricación*. Consiste en que pueden crearse mensajes falsos o desligados de la realidad, con determinadas intenciones. La mentira se basa en esta propiedad, la cual adquiere su máxima expresión en los mitómanos, quiénes cuentan hechos exagerados o grandiosos de los que fueron protagonistas, procurando que tengan cierta verosimilitud; al principio saben que son falsos pero, finalmente, llegan a creerse el relato. Véase como los mitómanos tienen que cuidar el mensaje para hacerlo creíble a sus interlocutores y prestar mucho cuidado a la manera de contarlo (función narrativa). Esta propiedad también se asocia a la creación de seres fabulosos, inexistentes en la realidad, que han formado parte de los grandes mitos (centauros, lamias, grifos, vampiros, etc.).

1.5.3. Canal. Entendemos por tal el medio físico de difusión de la información, pudiendo ser el aire, el teléfono, internet, papel, etc. Responde al *como* y tiene relación con la función fática, ya que esta se encarga de mantener el canal comunicativo abierto permanentemente.

En la comunicación habitual utilizamos el canal vocal-auditivo, donde el hablante utiliza el aparato fonador para producir un sonido y el oyente el sistema auditivo para recibirlo, pero eso no significa que no puedan emplearse otros canales, como estudiaremos en capítulos sucesivos.

1.5.4. Código. Ya sabemos que se trata del sistema de signos comunes a una masa de hablantes concreta, aunque también puede tratarse de acciones concertadas (p. ej. los movimientos de las banderas de los barcos, morse, etc.) o, incluso, pueden ser inventados por un grupo.

Sabemos que los ladrones utilizan dibujos conocidos por ellos, que colocan en lugares poco visibles de las puertas de las casas, de manera que informan a sus compañeros de si están en casa o de vacaciones, si vive allí un anciano/a, si el piso está vacío todo el día porque los dueños trabajan, etc.

El código responde a la pregunta *con qué*, tiene asignada la función metalingüística y se le reconocen estas dos características:

-La p*roductividad* que alude a que un sistema de comunicación puede crear y comprender sin dificultad un número ilimitado de mensajes nuevos. Cualquier hablante puede expresar algo que no ha dicho ni oído antes y ser perfectamente

comprendido por sus oyentes. Además, ni él mismo ni los demás parecen percatarse de la novedad de lo expuesto.

Esta propiedad del código se relaciona también con la capacidad de crear formas nuevas y originales de expresión, dando lugar a entender de una forma diferente un problema antiguo. Este fenómeno se utiliza en psicoterapia, donde un paciente trae a la consulta un asunto que no comprende demasiado bien, pero su capacidad de abordar mediante el lenguaje dicho problema le hace contemplarlo de una manera diferente, posibilitando el arreglo.

> *Una chica de 17 años recién cumplidos ha fracasado en los estudios y no sabe por qué. La realidad es que está faltando a clase desde hace algún tiempo y sin posibilidad de volver, ya que "no puede". La situación lleva un tiempo estancada, mientras la madre le exige constantemente que vaya a clase, lo cual le ha producido a la joven un importante estado de ansiedad (palpitaciones, dificultad para respirar, opresión precordial, inquietud, cansancio, etc.). Cuando llega a la consulta no entiende su problema y dice no saber qué le ocurre. Tras un tiempo de darle vueltas al asunto, abordándolo de distintas maneras, se da cuenta de que quiere estudiar enfermería por su madre, pero no es su deseo, dado que a ella no le gusta esta profesión. Finalmente, la creatividad de su lenguaje le permite darse cuenta de su verdadero deseo: ser esteticista.*

-La *transmisión cultural,* quiere decir que este sistema se transmite de una generación a otra, interviniendo en el proceso la tradición y el contacto con el grupo humano de pertenencia. Volveremos a este asunto.

1.5.5. Receptor. Aquella persona que capta el mensaje y lo descifra, aunque también puede ser un grupo (p. ej. en una conferencia o en una reunión de comunidad). Responde a la cuestión de *a quién* y se encarga de la función promotora, ya que el hablante pretende conseguir algo del receptor, influirle o moverlo en una determinada dirección; de ahí que se trate de una función de llamada. El receptor cumple las siguientes propiedades:

-La *intercambiabilidad.* Significa que los sujetos que participan en la comunicación pueden actuar como hablantes u oyentes indistintamente; dicho de otra manera: los papeles de emisor y receptor pueden alternarse. Si esto no ocurriera, hablaríamos de monólogos.

-Al mismo tiempo, el receptor tiene a su cargo la decodificación, que consiste en la capacidad para descifrar mensajes; la condición necesaria y suficiente es poseer el mismo código que el emisor.

Pero, no podemos suponer al receptor como un mero agente pasivo, ya que es capaz de aceptar o rechazar el mensaje o, llegado el caso, cortar la comunicación si no le interesa (p. ej. si mi interlocutor me falta el respeto o es grosero conmigo, puedo terminar ahí la conversación); por consiguiente, suponer un papel activo en el receptor resulta básico.

Al mismo tiempo, el emisor recibe la señal indicativa de que el receptor ha comprendido (*feed-back* o retroalimentación). No obstante, el modelo de Lasswell (8) no contemplaba este supuesto, pues manifestaba un carácter lineal.

1.5.6. Contexto. Consiste en las circunstancias que rodean al acto comunicativo o en lugar donde este se produce. Responde a las cuestiones de *dónde*, *por qué* y *para qué* y matiza la comunicación; quiere decir que nos relacionamos de manera diferente según el sitio donde nos encontremos, de acuerdo con las personas con las que estemos, el evento o acontecimiento en el que participemos o lo que esté ocurriendo en ese momento (p. ej. un médico no se comporta igual en su consulta que con sus amigos o en la playa).

El contexto tiene a su cargo la función informativa, dado que esta se asocia a los hechos que están sucediendo en ese instante. Incluso el contexto puede darle un sentido a las palabras que utilicemos, cambiando el significado de las mismas (p. ej. no es lo mismo decir “fui al *banco* a sacar dinero”, que “me senté en un *banco* del parque” o “vimos a lo lejos un *banco* de peces”). En cualquier caso, resulta muy interesante diferenciar entre:

-Contexto material (*donde*), relacionado con el lugar en el que mantenemos una conversación (p. ej. una clase de Medicina se imparte en un aula).

-Contexto simbólico (*por qué* y *para qué*) o conjunto de reglas de estricta observancia que se dan en ese lugar concreto donde estemos (p. ej. si asisto como alumno a una clase tengo que ir correctamente vestido, no puedo ir en bañador, no puedo fumar, no está permitido consumir drogas, etc.)

Una idea que no se puede escapar es la siguiente: la comunicación nunca puede ser completa, es decir que en el acto de habla todo no puede quedar explícito; esto solo podría ocurrir si se tratase de un intercambio ideal. En Medicina queda aún más claro, ya que el paciente nunca puede decirlo todo, siempre existen elementos propios que nunca serán comunicados. Contar con esta posibilidad obliga a pensar que el “control absoluto” es imposible y mucho menos en nuestro campo de trabajo.

Dado que cualquier mensaje es una propuesta de relación al interlocutor, sea cuál sea dicho mensaje, hay que contar con el *metamensaje* (literalmente “más allá del mensaje”, que transmite la intención del hablante (p. ej. la expresión “échate” puede contener: una sugerencia, un afecto, una propuesta erótica, una orden, etc.). El *metamensaje* se halla en el nivel de relación (no en el de contenido) y no puede ser captado directamente sino inferido a partir de las manifestaciones conductuales de quién emite el mensaje (mímica, gestos, entonación, pausas, etc.). Solo el delirante “ve” u “observa” cuál es la intención de su interlocutor con absoluta claridad.

J. es un paranoico, de 45 años de edad, que afirma con rotundidad que en su trabajo "están en su contra" y "le hacen la vida imposible". Cuando le preguntan: "¿cómo estás?" lo hacen con cierta sonrisilla, lo que indica claramente que "se están burlando de mi". Si le preguntan por su madre, con la que convive, está claro que "están espiándome y saben de mi vida". En la consulta realiza numerosas afirmaciones como estas y, en ningún momento, duda de la veracidad de las mismas. El "sabe" qué está sucediendo a su alrededor y cómo lo tratan.

El mensaje puede ser verdadero o falso, oportuno o inoportuno (de acuerdo con el contexto), pero es el *metamensaje* el que da las pistas adecuadas sobre cómo interpretar correctamente el mensaje (p. ej. una persona generar una frase de contenido amable porque intenta venderme algo, pedirme mis apuntes o hacerme una propuesta sexual). Curiosamente, el *metamensaje* puede afectar negativamente a un mensaje positivo; esto explica que nos sintamos incómodos con ciertas personas, aunque utilicen palabras corteses o educadas. La existencia de esta permanente división, de la que ya dieron cuenta los teóricos del Colegio Invisible, hace que se produzcan numerosos malentendidos, dado que el *metamensaje* no suele hallarse en el plano de la conciencia. De nuevo tendríamos que plantearnos las frecuentes incongruencias presentes en la comunicación humana, que ahora se plantean en el plano de las posibles diferencias entre mensaje y *metamensaje.*

Otro efecto que altera la comunicación se produce cuando esta solo se tiene en cuenta el mensaje, como ocurre con el *whatsapp*; entonces, suelen producirse numerosos malentendidos dado que, si el *metamensaje* no aparece, no es posible la intención del interlocutor. A tanto ha llegado este fenómeno que ha dado lugar a rupturas de relaciones amistosas, familiares e, incluso, sentimentales.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN	FUNCIONES ASOCIADAS
EMISOR	EXPRESIVA
MENSAJE	NARRATIVA
CANAL	FÁTICA
CÓDIGO	METALINGÜÍSTICA
RECEPTOR	PROMOTORA
CONTEXTO	INFORMATIVA

Para terminar este Capítulo intentaremos, a modo de ejemplo, aplicar este esquema a la comunicación a la Medicina y así poder definir los distintos elementos tal como se dan en una consulta.

-El emisor (*quién*): el médico.

-El mensaje (*qué*): puede ser un diagnóstico (p. ej. “tiene una depresión”), que a veces puede tratarse de una mala noticia (capítulo 11º).

-El canal (*cómo*): oralmente.

-El receptor (*a quién*): el paciente.

-El código (*con qué*): ambos interlocutores utilizan el mismo idioma (castellano) y, por lo tanto, emplean los mismos signos con los que pueden entenderse.

-El contexto: va a definir las características de la relación entre estos dos personajes y el propósito de la misma:

-Lugar (dónde): en una consulta médica.

-Propósito o sentido: a demanda del paciente, debido a su sintomatología (*por qué*), con idea de aliviar el sufrimiento (*para qué*).

En lo referente a la “codificación” hay que decir que depende de las habilidades comunicativas del médico. Un objetivo claro de la Comunicación Asistencial será desarrollarlas, para que el estudiante pueda saber cómo entrevistar al paciente, darle una mala noticia o poder relacionarse con distintos colectivos que pueden solicitar su ayuda. La “decodificación” se relaciona con factores relativos al paciente (actitud ante la consulta y el médico, aceptación/negación de la enfermedad, personalidad, etc.).

En cualquier caso queda claro que el médico está destinado a afinar la captación tanto del *mensaje* como del *metamensaje* implícito en los actos que acompañan a las palabras de sus enfermos; para lograrlo, resulta preceptivo que desarrolle cierta sensibilidad en la percepción de elementos (muchas veces ocultos), de una relación en la que él mismo se encuentra implicado como sujeto. Pero, no nos precipitemos porque, a lo largo de los próximos temas, tendremos ocasión de referirnos a cómo lograrlo.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Alonso Fenández F. Fundamentos de la Psiquiatría Actual (vol. 1). Madrid: Paz-Montalvo, 1979.
2. Peirce CS. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974.
3. Castiilla del Pino C. Introducción a la Psiquiatría (vol. 1). Madrid: Alianza Universidad, 1993.
4. Jakobson R. Ensayos de lingüística general. Barcelona: Planeta, 1985.
5. García Arroyo JM. El cáncer de mama (1): reacciones ante el diagnóstico. Dis-Capaz, 2011.
6. Bateson G, Ruesch J. Comunicación. La matriz social de la psiquiatría. Barcelona: Paidós, 1984.
7. Watzkawick P, Beavin J, Jackson DD. Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas. Barcelona: Herder, 1981.
8. Lasswell H. The Structure and Function of Communication in Society, 1948.

Capítulo 2º.- Comunicación y espacio social. Comunicación verbal y no verbal. La proxemia.

La comunicación humana es un fenómeno bastante complejo, de ahí que englobe un gran número de comportamientos y actuaciones, que constituyen una larga serie: vestimenta, palabras, movimiento de manos, miradas, perfumes, tono de voz, abalorios, maquillaje, movimientos, joyas, complementos, etc. y todos ellos tienen lugar en ese marco continente que es el contexto. Pero, este vasto conjunto de elementos puede agruparse (de manera didáctica y ordenada) en tres apartados:

-el lenguaje,

-los gestos y

-el espacio donde tiene lugar la comunicación.

Este segundo Capítulo tiene como objetivo principal analizar con detenimiento cada uno de ellos.

2.1. La comunicación verbal.

2.1.1. Los signos verbales. Solo el ser humano posee la capacidad para comunicarse con sus semejantes mediante ruidos originados en el cuerpo, capaces de ser entendidos y que permiten producir y recibir la información implícita en ellos; es la forma más diferenciada de comunicación que existe. Por lo tanto, la comunicación verbal consiste en aquella forma de interaccionar con los semejantes que se basa en la capacidad específica del humano para transmitir mensajes mediante signos vocálicos, los cuáles conforman un lenguaje articulado. Esta acción requiere la existencia de un aparato fonador y de unos centros nerviosos específicos que regulan su funcionamiento.

Los signos a los que nos referimos no son sucesos naturales, como pueden ser:

-el humo que advierte de la presencia de un fuego,

-la nube negra que presagia lluvia,

-las cefaleas que implican la existencia de fiebre,

-las manchas rojas que aparecen en el sarampión, etc.

En estos casos, Peirce hablaba de “índices” (1). Es importante darse cuenta de que: en ninguno de ellos interviene la acción humana, ni manifiestan una intención comunicativa y tienen el carácter de ser universales.

En cualquier lugar del mundo, el sarampión, la escarlatina, la tabes dorsal o la diabetes se muestran de la misma forma y con la misma evolución. Eso

hace posible que se pueda estudiar Medina en Sevilla o en Honolulú, porque el aprendizaje de la clínica es el mismo.

Por otro lado, solamente los psicóticos encuentran mensajes en estos hechos naturales. Así, un paciente esquizofrénico, tras una fuerte lluvia que llenó las calles de Sevilla de un barro rojizo pensó, al ver este efecto, que "le iban a chupar la sangre mientras dormía". Otro paciente con el mismo diagnóstico, interpretó las nubes negras como un "mal presagio", dado que "las ondas espaciales que utilizaban sus enemigos para controlar su voluntad, podían tener más efecto si el tiempo era adverso".

En cambio, los signos (vocálicos) que empleamos para comunicarnos son símbolos (1), convenciones creadas por una masa de hablantes y que, por lo tanto, no pertenecen a la naturaleza (como los "índices") sino a la cultura. Puede tratarse de canciones, palabras, tradiciones orales, chistes, mítines políticos, poesía, adivinanzas, letra de los bailes, etc. La diferencia entre los gritos de los animales y el lenguaje humano consiste en que los primeros son sucesos naturales (llamada), mientras que los segundos son culturales.

Los signos (palabras) que utilizamos poseen la característica de representar algo, quiere decir que ocupan el lugar de otra cosa, de ahí que su papel sea de símbolo (1).

Si trato de explicar a alguien qué es un elefante, no tengo que traerme a este animal de África o de la India y ponerlo delante de mi interlocutor, simplemente hablo de él. La palabra "elefante" sustituye en el discurso al paquidermo, de ahí que actúe como símbolo.

Hay que fijarse también en que las palabras no son como los iconos, que estudiamos en el capítulo anterior, dado que en aquellas no existe una correspondencia física con el objeto al que representan; así, el vocablo "perro" no tiene nada que ver con el animal y, de hecho, en inglés se dice de una manera (*dog*), en francés de otra (*chien*) y en alemán de una forma muy diferente (*hund*). En cambio, en los iconos se establece cierta similitud geométrica entre la imagen y aquello representa.

2.1.2. Características. Detallamos las siguientes:

a) No es instintivo, sino que se adquiere por contacto con otros seres humanos, sobre la capacidad existente en el *homo sapiens* para poder hablar (desarrollo de ciertos centros y vías nerviosas y de un aparato fonador). De ahí se sigue, que aquellos sujetos que han permanecido durante largo tiempo fuera de la civilización, y sobre todo en ciertos momentos cruciales para adquirir esta habilidad, no hayan desarrollado el lenguaje. Volveremos luego sobre el tema.

b) Se atiene a un código que, en el caso de la comunicación verbal, se denomina "lengua" (2); no es el "lenguaje", por tratarse este de un término muy contaminado por otras disciplinas (psicología, antropología o sociología). La lengua contiene los distintos signos lingüísticos comunes a un grupo humano y

que potencialmente pueden emplearse. La utilización por parte de cualquier individuo de los distintos elementos de la lengua, es el "habla" (2); entonces, mientras la lengua es general, el habla es particular, tratándose del uso que cada cual hace de la lengua.

El uso práctico que un sujeto hace del código tiene relación con la inteligencia pues, aunque contemos todos con el mismo conjunto de signos, la persona que tiene cierto nivel (intelectual) posee más acepciones para la misma palabra y también un mayor número de palabras para designar al mismo objeto. Veamos un ejemplo:

> *La palabra "llave", para una persona con mayor contenido verbal, tiene bastantes más significados que para otra que no lo tenga, pudiendo significar: 1) instrumento para abrir una puerta, 2) conmutador, 3) forma de hacer presa en el contrario en la lucha, 4) herramienta para aflojar una tuerca. Incluso, podría alcanzar este otro: cuña de madera que se introduce en la horma para ensanchar el calzado.*

c) Posee una estructura sintáctica consistente en una combinatoria formal precisa, que da lugar a una secuencia que no puede alterarse, lo que permite crear y transmitir un sentido. Trátase de un conjunto limitado de reglas abstractas incorporadas subjetivamente, cuyo empleo se realiza automáticamente y sirven como modelo para las diferentes manifestaciones concretas (habla).

De nuevo son los esquizofrénicos los que alteran sobremanera la sintaxis, apareciendo expresiones sin sentido, como es el caso del paciente que afirmó: "Yo soy sobre tres millones por herencia" (3). Ello implica que el respeto a la sintaxis es fundamental para que se produzca el sentido deseado.

d) El conjunto de los signos empleados en un orden correcto va a organizarse como un **discurso**. Su existencia se sostiene en la característica vista en el apartado anterior (poseer un sentido), a la que se añade el contenido que puede ser de distinta naturaleza (político, científico, estético, religioso, educativo, médico, etc.). Tener en cuenta el discurso significa atender al proceso social o interpersonal de la comunicación verbal (4).

Ahora bien, el discurso puede ser:

-Oral: adopta la forma de secuencias sonoras captables sensorialmente por el interlocutor (comunicación oral).

-Escrito: trazos en el papel o señales luminosas en una pantalla de móvil o de ordenador.

2.1.3. Funciones. Conviene retener las que se detallan seguidamente:

A) Representar. Significa realizar una copia de algo. Podemos hacerlo con el mundo que nos rodea (p. ej. describir una enfermedad o cómo es mi consulta), pero también es posible representarse a uno mismo (al propio *yo*). Al hacer esto lo que mostramos es nuestra identidad, que se encuentra vehiculizada a través del lenguaje: nombre, apellidos (estos nos entroncan con una familia), nivel de estudios, profesión, lugar de residencia, preferencias y elecciones, etc.

> *Puede verse con claridad este fenómeno cuando nos presentamos a alguien que acabamos de conocer, en cuyo caso, o bien vamos exponiendo los diferentes aspectos de nuestra identidad ("me llamo Rosa", "estudio filología inglesa", "aún vivo con mis padres", etc.) o lo hacemos respondiendo a las preguntas que nos van formulando, muchas de las cuáles son ya un tópico ("¿vives por aquí?", "¿estudias o trabajas?", "¿sales con alguien?", etc.)*. *Las personas extrovertidas son más capaces de exponer espontáneamente aspectos diferentes de su personalidad, mientras que a los introvertidos les cuesta gran trabajo, porque suelen ser bastante reservados.*

En la demencia se pierden estos símbolos y el resultado es que el sujeto se desorienta: primero temporalmente (no sabe en qué día, mes o año vive), luego espacialmente (no recuerda donde vive o en qué lugar está ubicado ahora) y, finalmente, cuando se desploma la estructura psíquica, se pierde la orientación respecto al *yo* y no sabe quién es (no conoce su nombre, apellidos, familia,..). El orden es siempre el mismo: desorientación alopsíquica (temporal y espacial) para acabar en desorientación autopsíquica (respecto al *yo*).

B) A través de la comunicación verbal también podemos **transmitir experiencias**. como pueden ser: viajes, recuerdos, entrevistas profesionales, deseos realizados, afecto hacia alguien, relaciones sentimentales, etc. El lenguaje es el medio idóneo para informar a los demás de qué pensamos o sentimos y con ello se favorece la relación y actuación con el entorno.

Incluso el lenguaje sirve para desarrollar nuestros pensamientos e ideas y para aclarar los estados afectivos; del mismo modo, las alteraciones del lenguaje van a repercutir en la vida intelectual del sujeto y en sus relaciones sociales. Esta propiedad se utiliza en psicoterapia, en la que paciente aclara qué siente, cómo ha vivido algo o pensar en cómo tiene que actuar ante una determinada situación.

C) **Control del comportamiento**. El lenguaje interviene controlando nuestras acciones y, sobre todo, los impulsos (sexuales, agresivos), que se constituyen en la parte insociable del ser humano, dada su potencialidad dañina sobre los demás. Hablamos de la naturaleza animal que existe en el ser humano y que Freud adscribió al *ello*, en tanto "reservorio de pulsiones".

Hay que aclarar que la Ley no es solo un elemento externo al sujeto que le prohíbe ciertas cosas (p. ej. no está permitido pegar, ni lavarse los dientes en la calle, ni salir en ropa interior, etc.), sino que también es "interna" y desde dentro,

desde la subjetividad, impide la realización de ciertos actos. En cambio, los psicópatas son individuos que no tienen incorporada la Ley y, por consiguiente, pueden realizar comportamientos desadaptativos. Tanto la Ley "externa" como la "interna" vienen escritas en palabras y el sujeto las incorpora a lo largo de su proceso educativo. Si el niño no convive con los demás, no puede efectuar este proceso de incorporación; es lo que sucede con los llamados "niños ferales" o "síndrome de Kaspar-Hauser": personas apartadas de la sociedad durante un periodo largo de su infancia.

Kaspar-Hauser era un adolescente que apareció en 1828 en la ciudad de Nüremberg con una carta en la mano en la que solicitaba que se hicieran cargo de él. Nunca se averiguó su procedencia y se especuló bastante (se pensó que era descendiente de la casa de Baviera, reinante por entonces, o del mismísimo Napoleón); lo único que se supo es que creció encerrado en un sótano oscuro aislado del mundo. Decía pocas palabras y no se le entendía casi nada, presentando respuestas extrañas a las distintas situaciones sociales. Una historia en que ha inspirado numerosos relatos (Tarzán, El libro de la selva, etc.).

Se han estudiado un puñado de casos en el mundo, algunos muy conocidos, como fue el de Victor de Aveyron, que apareció en el Langedoc francés, en el s. XVIII y que fue estudiado por el mismísimo Pinel (el primer psiquiatra que liberó a los alienados de las cadenas). Otros son el "niño-lobo" español o la "niña-pollo" de Portugal; en estos se observa cómo imitan las conductas de los animales con los que criaron, en detrimento de comportamientos más humanizados.

Los "niños ferales" demuestran que el lenguaje es fundamental para convivir, pues son individuos que no aprenden a hablar y a caminar erguidos (bipedestalismo) y tampoco asumen las normas, impidiéndose una convivencia adecuada. Sin el concurso del lenguaje, resulta imposible la eclosión del pensamiento abstracto (lógico-racional) y, necesariamente, surgen problemas ulteriores en la construcción de la realidad (de carácter social).

D) Finalmente, el lenguaje se emplea para **engañar**. Voltaire decía que: "la palabra sirve para mentir". Efectivamente, cuando se habla se ocultan aspectos de la realidad personal, se deforman otros, no se cuenta todo lo que se sabe e, incluso, se formulan hechos falsos que completan lo que en la realidad falta. Hemos hablado anteriormente de la *prevaricación*, en tanto posibilidad de articular mensajes falsos o desligados de lo externo (ver Capitulo 1º). Ya veremos que los pacientes no pueden ser menos y también mienten y ocultan contenidos a sus médicos.

2.2. La comunicación no verbal.

2.2.1. Concepto. A la comunicación no verbal ha recibido menor atención y se le han dedicado menos estudios científicos que a la verbal, debido a que: 1º)

se encuentra menos estructurada y 2º) es más difícil de interpretar. Esto explica que durante el Bachillerato a los estudiantes se les imponga el estudio del Lenguaje durante varios cursos y, sin embargo, se tratan muy poco las manifestaciones que utilizamos para intercambiar contenidos de forma extraverbal.

A esto se añade que, en la vida diaria se suele dar poca importancia a lo que está fuera del lenguaje y hasta se cree que con este basta para comunicarse. Ocurre a diario: estamos ante una persona que nos convence con la palabra, pero después desconfiamos de ella o no nos sentimos cómodos. De ahí que, tener en cuenta lo no verbal en el proceso comunicativo se convierte en una tarea importante, aunque no podamos considerarlo en exclusiva.

El término “no verbal” empieza a utilizarlo un psiquiatra de la Escuela de Palo Alto, llamado Jürgen Ruesch, quién (en 1956) publica un libro titulado: *Nonverbal communication* (5). En este conocido texto presenta el asunto acompañado de una abundante documentación gráfica, aportada por el conocido fotógrafo Weldon Kees. Se trata del proceso de comunicación que opera mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, en forma de actos, y que carecen de una estructura sintáctica. Así pues, son tres las ideas que definen este tipo de interacción comunicativa:

-la ausencia de palabras,

-hallarse constituida por acciones, quiere decir por realizaciones observables en las que se halla implicado el aparato muscular, como queda plasmado de forma clara en el gesto constreñido de la cara, en una postura corporal mantenida o en el puño apretado que golpea la mesa mientras se habla y

-carece de la formalización inherente a la comunicación verbal, que ha permitido numerosos estudios sobre el lenguaje (incluidos los matemáticos o los lógico-formales).

C. VERBAL	**C. NO VERBAL**
Discurso	Acciones
Sintaxis	Ausencia de sintaxis

2.2.2. Componentes. La comunicación no verbal muestra una serie de componentes que conviene conocer, ya que tienen gran importancia observarlos en los pacientes.

a) Gestos. Se trata de movimientos corporales (p. ej. alzar la mano para preguntar en una reunión, tocarse la cabeza cuando duele, etc.).

b) Postura corporal. Implica una posición mantenida que puede relacionarse con cualquier segmento del cuerpo, como es la posición de brazos, manos, piernas, etc. (p. ej. situar la cabeza entre los brazos dejándola caer cuando en estado de agotamiento).

c) Mimica. Se trata de la expresión facial y se relaciona con: muecas, ceño, sonrisa, cierre/apertura de los párpados, sonrisa, posición de los labios, etc. (p. ej. la apertura excesiva de los ojos cuando aparece algo sorprendente).

Aquí hay que considerar, de manera especial, a las llamadas "microexpresiones", que suelen pasar desapercibidas para quién las realiza y también para quién las recibe y, sin embargo, tienen un gran interés porque delatan a la persona (p. ej. sonrojarse, abrir la boca ante un desconcierto). Paul Ekman ha estudiado este fenómeno en relación a la mentira (6).

d) Mirada. Se incluyen aquí: el contacto visual, el reojo, la mirada esquiva, etc. (ej. la dirección de los ojos hacia el suelo en la persona apesadumbrada).

e) Paralenguaje. Son las actuaciones que acompañan a la emisión verbal (movimientos de manos, cabeza, dedos, etc.), junto a las variaciones de la voz (volumen, intensidad, acento, elevación del tono, secuencia, repetición, pausas, ritmo, silencios, etc.) (p. ej. subir el tono para enfatizar algo que se está diciendo o para indicarle a alguien que aquello que ha hecho está mal).

f) Finalmente, hay que considerar elementos de una gran complejidad, como pueden ser: vestimenta, peinado, perfume, danza, rituales, maquillaje, tatuajes, anillos, adornos con motivos religiosos (medallas o crucifijos), etc. Cualquiera de ellos se encuentra fuertemente matizado por la cultura en la que el sujeto se incluye.

> *Un ejemplo característico es el obi de las japonesas. Estas mujeres utilizan el kimono, pero dicha vestimenta es igual en las geishas que en las prostitutas, pero ¿existe algo en su vestimenta que las diferencie? La respuesta es afirmativa. Antes que nada, hay que tener en cuenta que las geishas no son prostitutas y jamás pueden confundirse con ellas; son damas de compañía que hacen agradables las reuniones (p. ej. de negocios), mostrando ciertas habilidades (cantan, tocan algún instrumento, recitan, saben conversar, etc.). La diferencia se encuentra en el obi, que es el cinturón que cierra el kimono; pues bien, las geishas llevan el nudo detrás, mientras que las prostitutas lo tienen delante. Se trata de una distinción que, en principio, parte de la utilidad (se necesita ayuda ajena para hacer bien el lazo y las prostitutas no la tienen, mientras que las geishas sí) pero, además, es un rasgo distintivo que hace que puedan diferenciarse con claridad.*

2.2.3, Funciones. Señalamos las siguientes:

A) Sustituye al lenguaje verbal. El caso característico es el alfabeto de los sordos, donde se ha procurado amarrar cada gesto o movimiento a un significado concreto, cosa que no sucede en condiciones normales.

En menor medida, cuando alguien tiene cierta pobreza en palabras recurre a expresiones no verbales, mostrando una exageración de gestos y ademanes; a veces, estas personas presentan unos rasgos faciales demasiado pronunciados, poniendo de relieve la utilización excesiva de la mímica.

B) Matiza al lenguaje verbal. Transmite una información adicional: subraya, acentúa, modifica, puntúa, etc. Aquí hay que considerar la posibilidad de que se produzcan contradicciones entre lo verbal y lo no verbal. Veamos un caso:

> *Se trata de una mujer de 51 años que recientemente ha perdido a un hijo, que nació con una malformación congénita y no ha podido soportar las intervenciones que le hicieron (cateterismo). A pesar de que su verbalización es trágica, acude a la consulta muy maquillada y habla con una amplia sonrisa. Se le hace notar la contradicción entre sus palabras y sus gestos, asintiendo; responde, posteriormente que ella necesita agradar a los demás, por eso "siempre tengo una sonrisa en la boca".*

C) Expresa el modo de relación. Mientras lo verbal transmite sobre todo información, no pone de manifiesto la relación entre los hablantes. Lo no verbal es limitado para el discurso, pero muestra la actitud o conexión afectiva del sujeto en el acto comunicativo e, incluso, las mismas palabras (nivel verbal) pueden ser empleadas con una intención u otra (nivel no verbal).

> *En nuestro medio expresiones frecuentes como: "¡hola, hijo puta!" pueden contener un saludo amistoso, un insulto o una amenaza. Aunque la oración sea la misma en cualquiera de los casos, aquello que la acompaña (tono, expresión facial, cercanía/lejanía, etc.) es lo que define la forma de contactar con el otro y, por supuesto, la respuesta de este último.*

Al mismo tiempo, aquellas circunstancias en las que lo no verbal no muestra un desarrollo normalizado, puede poner bastante nervioso al interlocutor debido a no saber con exactitud el tipo de contacto que establece. Tal es el caso de la inexpresividad del enfermo parkinsoniano o de situaciones de entrevistas, pruebas o juicios, en las que el examinador o el juez muestran una inquietante "cara de poker". Además, habría que considerar que los obsesivos/as intentan ocultar lo que sienten (que no se note cómo se encuentran), mientras que los histéricos/as pretenden que se conozca cuanto sufren, de ahí sus exageradas manifestaciones extraverbales.

D) No miente. Antes se dijo que lo verbal servía para mentir, dado que la relación del hablante con su interlocutor queda oculta por el lenguaje verbal.

Este es el caso del seductor, del que ya hemos hablado. Mientras habla a su compañera temporal de algo que cree le interesa y crea con ella un contacto afectivo mediante el lenguaje, su intención queda oculta tras esas bellas palabras (es una persona elocuente).

La mentira es más factible en el plano verbal porque, como sabemos, es más fácil hablar de una alegría que no siento que ponerme contento sin sentirlo; para lograrlo, y que los demás no se den cuenta, tengo que ser un actor consumado.

En un momento u otro, prácticamente todos nos hemos visto envueltos en una invitación a almorzar que nos ha hecho alguien que cocinaba fatal. Entonces, hemos tenido que fingir que estábamos disfrutando su comida; en ese momento, pudimos comprobar lo difícil que resultaba fingir y lo fácilmente que podíamos ser pillados en el engaño.

En cualquier caso, es importante saber que son las microexpresiones las que delatan a la persona, debido a su incontrolabilidad; podríamos decir que escapan al control porque se expresan más allá de la conciencia del propio sujeto.

2.2.4. La indecibilidad de los actos. Terminamos este apartado hablando de que lo no verbal es **indecible** y haciendo la advertencia del cuidado que hay que tener al realizar las correspondientes interpretaciones, sobre todo si las acciones del sujeto no se acompañan de aquellas palabras que expliquen por qué ha realizado un determinado acto. Pondremos un ejemplo que lo clarifica bastante bien:

Por la calle Luis Montoto pasaba un señor de mediana edad que siempre llevaba un brazo en alto. Era la comidilla del barrio y se hicieron numerosas interpretaciones por otras tantas personas: 1ª) que jugaba al tenis y tenía un "codo de tenista" que le provocaba gran dolor, 2º) que tenía un "golondrino" (inflamación del ganglio) en la axila y no podía mover el brazo, 3º) que era un hombre muy amigable y siempre saludaba a alguien, 4º) que se trasladaba en taxi y llamaba en ese momento a alguno. En algunos casos, quiénes realizaron estas conjeturas aportaron alguna prueba a favor de sus argumentos ("yo lo vi jugando", "llamó a un taxi en mi presencia", "habló con una chica", etc.). El caso es yo sabía que todos estos comentarios eran falsos, porque conocía al individuo en cuestión: era un psicótico residente en un piso protegido y deliraba con la figura de Franco y tenía el brazo levantado porque cantaba el "Cara al Sol".

Vemos pues, que la interpretación de los actos es sumamente complicada y, para realizarla, hay que tener en cuenta los siguientes elementos:

a) El contexto cultural. Darwin se equivocó cuando, en 1872, publicó un libro titulado *Las expresión de las emociones en los animales y en el hombre (7)*, pues llegó a decir: "Los humanos tienen en todos los contextos culturales elementos de expresión que son comunes". A medida que la antropología socio-cultural se ha ido desenvolviendo, ha demostrado con cierta claridad que las

mismas emociones tienen expresiones diferentes en lugares distintos de nuestro Planeta, de acuerdo con los códigos culturales imperantes. Aunque este asunto lo desarrollamos con la extensión debida en el Seminario de Comunicación Afectiva, advertimos, desde este mismo momento, que el médico hoy en día tiene que tratar personas procedentes de diferentes lugares geográficos, de ahí que tenga que muy cauto a la hora de entender los distintos gestos o actos que estos sujetos realicen en su presencia.

b) El contexto personal. Existen actuaciones repetidas dentro grupo al que la persona pertenece, como es el caso de la familia; dichos movimientos son característicos de ese colectivo y solo son posibles de comprender si se conocen las claves que solo sus miembros poseen.

> *Este es el caso de una chica de 19 años que acude por un cuadro de ansiedad. En la consulta aparece como una persona afable y, a pesar de su buen nivel de expresión verbal, cada vez que aparecen en la sesión ciertas temáticas, hace un gesto característico; consiste este en levantar la mano hacia arriba, con la palma al frente. Dicho gesto es bastante repetitivo y no se puede saber qué significa, dado que la paciente no lo ha explicado. También apareció la madre por mi consulta y, curiosamente, hacía el mismo gesto al hablar de determinados asuntos problemáticos. Preguntada por el significado, respondió: "mire usted, este ademán lo hemos hecho siempre en mi familia y significa `me importa un coño´ pero, como la palabra es tan fea, es mejor hacerlo y nos quedamos tranquilos sin decir el taco".*

3. La proxemia.

3.1. Concepto. Entramos en la última parte del Capítulo 2º abordando uno de los aspectos más importantes de la comunicación: aquel que se relaciona con el espacio en el proceso comunicativo y que va a tener una gran aplicación al campo de la Medicina.

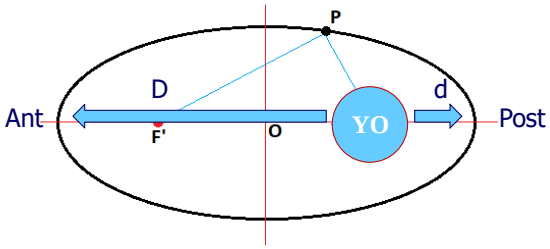
El término *proxemia* (o *proxémica*) fue utilizado por primera vez por el antropólogo Edward T. Hall, en 1963 (8), para describir las distancias medibles entre las personas mientras interactúan. Se puede decir que el gran logro de este reconocidísimo antropólogo fue describir la "distancia conversacional", dando cuenta con ello de la percepción y el uso del espacio en las relaciones interpersonales. La proxemia revela la tendencia que todos tenemos a marcar el territorio personal mientras nos comunicamos, un aspecto que tiene que tiende a mantenerse de forma constante. Luego, existe una relación entre la distancia social y la distancia física:

$$ds \equiv df$$

Geométricamente la proxémia tiene la forma de una elipse. Como sabemos una elipse tiene dos focos, pues bien el *yo* ocupa uno de estos focos, siendo el eje mayor el anterior (D) y menor el posterior (d). Esta disposición particular se

debe a que, al relacionarnos con los demás, los órganos sensoriales más importantes (los "sentidos lógicos"), como son la vista y el oído, se encuentran dirigidos hacia delante. Mientras tanto, hacia atrás no podemos tener esa misma forma de captar el medio externo. Curiosamente, el paranoico, que es un sujeto desconfiado y suspicaz, al tener que estar vigilante de cuánto sucede a su alrededor, la elipse se convierte en un círculo con el *yo* ubicado en su centro.

Forma geométrica de elipse



D > d

Paranoico: D = d

3.2. Tipología. Lo expuesto hasta ahora lleva a tener que considerar cuatro tipos de distancia:

1ª) Pública. Se da entre desconocidos o en la relación con grupos (p. ej. en una conferencia). No se produce un contacto entre los personajes que interactúan.

2ª) Social. Es el caso de entrar en contacto con personas de la vida cotidiana (p. ej. vecino, albañil, dependienta del supermercado, mancebo de la farmacia, etc.). El contacto es esporádico y solo se produce el acercamiento si hay una justificación para ello (p. ej. felicitar el cumpleaños).

3ª) Personal. Aquí se trata de una relación con personas cercanas (p. ej. compañeros de oficina, de cursos, en reuniones, fiestas, etc.). El contacto es más frecuente y también más cercano.

4ª) Intima. Es la más próxima de todas y se encuentra limitada a personas con las que existe mucha confianza (p. ej. amigos muy cercanos, pareja, familia, etc.). El contacto se encuentra permitido.

Las normas que regulan la proximidad-alejamiento funcionan de manera automática: sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, sin necesidad de realizar un acto reflexivo. Véase que en la proxemia la relación afectiva es inversamente proporcional a la distancia física (mientras más cercana es una relación, menos proximidad). También conviene retener que

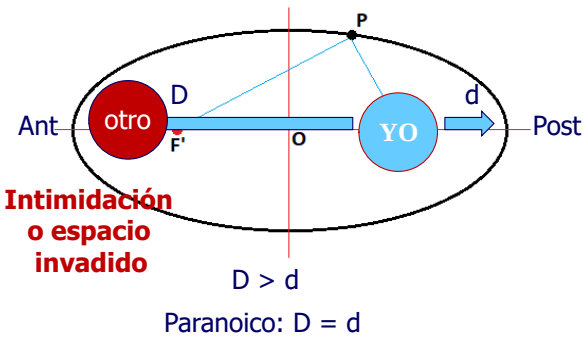
existe una asociación clara entre la proxemia y las formas de comunicación verbal y no verbal; efectivamente, a medida que disminuye el espacio físico, aumenta el contacto físico con más frecuencia de miradas, los gestos se hacen más expresivos, las posturas más desenfadadas y menos formales y las palabras más familiares y afectuosas. Esto tiene que ver con el aumento de la confianza que opera en estos casos.

DISTANCIA	RELACIÓN SUJETOS	CONTACTO
PÚBLICA	Desconocidos	No
SOCIAL	Personas vida cotidiana	Esporádico
PERSONAL	Cercanos	Frecuente
INTIMA	Mucha confianza	Permitido

Si se traspasa la distancia dependiente del tipo de conexión establecida, se produce la "sensación de intimidación" o de "espacio invadido"; de ahí que acercarse demasiado o tocar provoca sensaciones displacenteras que, en ocasiones, pueden llegar a ser bastante intensas (señal de angustia). En tales casos, es importante saber poner límites para que no aparezcan estas sensaciones desagradables.

> *A mi consulta acudía, hace ya tiempo, un representante de laboratorio que se acercaba en exceso, poniendo su cara cerca de la mía. Además, lanzaba bastante saliva cuando hablaba ("duchaba" a su interlocutor, podríamos decir). Había que apartarlo permanentemente, mientras él se justificaba diciendo que era de Sevilla y, por lo tanto, una persona bastante cercana y le gustaba la proximidad con la gente.*

Forma geométrica de elipse



3.3. Factores que intervienen. La proxemia varía de acuerdo con:

A) El sexo. Entre las mujeres tocarse o hallarse próximas es adecuado, pero no entre hombres, salvo situaciones muy concretas (p. ej. festejar un gol, ver la salida de una Cofradía). Incluso, cuando los hombres se abrazan porque tienen un trato amistoso, puede observarse como apartan la zona genital desplazando los glúteos hacia atrás. Esto parece deberse a estereotipos culturales aún vigentes que promueven el temor a la homosexualidad entre hombres.

Tampoco está bien visto que un hombre adulto se acerque demasiado a una joven, debido a las connotaciones eróticas que ese acto conlleva (que tiene mucho de interpretación). La excepción se halla en aquellos momentos en los que la situación se encuentra perfectamente definida en su cualidad, la cuál tiene que ser de naturaleza afectiva (p. ej. dar un pésame, felicitar por un ascenso).

B) El estatus. Este punto puede asociarse al "quinto axioma" de la comunicación. Si el estatus es más elevado ("relación complementaria") la distancia conversacional va a ser mayor (p. ej. entre el capitán y el soldado o entre un jefe y su empleado).

C) Los roles. También el papel que desempeña cada uno en la interacción influye en la proxemia; mientras más diferenciados o separados sean los roles, se requiere una mayor distancia.

> *Sabemos que los oficiales nazis utilizaban gorros militares con viseras bastante bajas, con idea de tener que elevar la cabeza al hablar con aquellos que no pertenecían a la raza aria. Ello provocaba un ademán de distancia y diferenciación con aquellos "seres" que jamás podía ocupar su lugar en la Alemania nazi y de los que tenían que defenderse.*

D) La cultura. Esta juega un papel determinante en relación a la distancia conversacional, resultando ser mayor en la interacción social propia de los países nórdicos, mientras que es más pequeña en la cultura latina. Dicho de otra manera: en nuestro medio la gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás; el acercamiento no es rechazado ni resulta incómodo, salvo por las restricciones mencionadas en los anteriores apartados. Conocer estos extremos permite mejorar las relaciones interculturales.

Se añade a lo anterior que, en ciertas culturas, un esposo no permite que un médico varón examine a su esposa, aún corriendo peligro; en nuestro medio una persona con estas características sería considerado un delirante celotípico.

E) La personalidad. Para acabar es necesario indicar que la personalidad también influye en las proxemia. Los fóbicos siempre se mantienen a una distancia de seguridad respecto a los demás, mientras que los histriónicos necesitan la proximidad algunos de los cuáles pueden ser "besucones" o "sobones". El extremo de la proximidad se da en sujetos perversos, a los que

llamamos *toucheurs* y *froteuristas*; mientras los primeros van tocando sin permiso a la gente en las aglomeraciones, los segundos son “especialistas” en refregarse. Evidentemente, ambos ocasionan una invasión angustiosa en sus víctimas.

En esta enumeración quedaría incompleta si no hablamos del alcohol o de las drogas, las cuáles provocan un cambio forzado en las distancias (de “pública” a “personal” o “intima”), al crear una cercanía sin base real y que, por lo tanto, tiene el carácter de ser ficticia. No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que el rechazo tan fuerte que provocan en las personas sobrias, se debe a la intromisión forzada del espacio ajeno.

Circunstancias actuales, como es la presencia del COVID-19 en la comunidad, ha provocado que la proxemia aumente considerablemente (por norma sanitaria) para evitar los contagios. Ello ha dado lugar a una disonancia entre la distancia afectiva (ds), que sigue siendo la misma, y la distancia física (df), que se ha modificado. Las personas que se han visto más afectadas por estos sucesos han sido aquellas que necesitaban más el contacto físico y las demostraciones afectivas (abrazos, caricias o besos). Particularmente, los/las histriónicos/as que no pueden estar solos, que siempre tienen que estar en compañía, que requieren de la presencia ajena, son los que más están sufriendo por las distancias forzadas. En cambio, los esquizoides o los fóbicos sociales no han notado apenas estas modificaciones.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Peirce CS. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974.
2. Saussure, F. (1990). Curso de lingüística general. Madrid: Alianza.
3. Delay J, Pichot P. Manual de Psicología (2ª ed.). Barcelona: Toray-Masson, 1969.
4. Halliday MAK. Lingüistic studies of text and discourse. London: Webster, 2002.
5. Ruesch J, Kees W. Nonverbal communication. Univ of California Press, 1956.
6. Ekman P. Como detectar mentiras. Barcelona: Paidós, 2009.
7. Darwin C. La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Madrid: Alianza, 1998.
8. Hall ET. La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio. Inst. de Estudios de Administración Local, 1973.